

分类号: C916

单位代码: 89622

密 级: 公开

学号: 2022045

中共吉林省委党校

吉林省行政学院

硕士学位论文

类型: ☐ 硕士学术学位

☒ 硕士专业学位

论文题目 : 园艺疗法疏解城市社区独居老人

抑郁情绪的小组工作研究

作者姓名: 潘俊霖

指导教师: 杨清哲

专业名称: 社会工作

研究方向: 社区社会工作

论文提交日期 2025 年 6 月

摘要

随着我国老龄化进程加速，城市社区独居老人规模持续扩大，独居状态导致的社会角色断裂、情感支持匮乏与生活风险叠加，使该特殊群体成为心理健康问题的高发人群。更关键的是，独居老人的心理问题常被忽视，他们往往不会主动寻求帮助，导致问题恶化。因此，关注并疏解独居老人的抑郁情绪，不仅是对个体的关爱，更是维护社会稳定的重要一环。

本研究以南京市 Z 社区为例，采用访谈法进行资料搜集，发现社区独居老人存在情绪低落且焦虑、兴趣减退、自我封闭以及不愿社交等方面的情绪问题，并从中归纳出独居老人的需求。以南京市 Z 社区的 20 位独居老年群体为研究对象，通过半结构化访谈和量表评估的混合研究方法，系统地探索园艺干预对抑郁情绪的缓解效能。研究结合马斯洛需求层次理论和社会支持理论，设计并实施七次主题式园艺小组活动，涵盖认知能力、活动能力、社会交往及自我效能感维度，通过植物辨识、绿植养护、社区花园共建等具体干预手段，引导独居老人建立自然联结与群体互动。

本文采用老年抑郁量表（GDS）对实验组和对照组进行前后测量，结果表明，干预后实验组的抑郁情绪呈现统计学意义的改善，最终在认知功能、社交能力和自我价值感等方面均有一定程度的提升。并借助《园艺疗法福祉效益评估表》证实园艺疗法的作用机制，体现在五感刺激延缓认知衰退、群体互动增强社会联结、技能训练提升活动能力等多维度协同效应。最后，对整篇文章进行梳理总结，提出建议，同时也对本研究不足之处进行了反思。

关键词：园艺疗法；独居老人；抑郁情绪；小组工作

Abstract

With the acceleration of the aging process in our country, the scale of the elderly living alone in the city continues to expand, and the state of living alone leads to the fracture of social roles, the lack of emotional support and the superposition of life risks, what's more, the psychological problems of the elderly living alone are often ignored. They often do not take the initiative to seek help, which leads to the aggravation of the problems, paying attention to and relieving the depression of the elderly living alone is not only the care for individuals, but also an important part of maintaining social stability.

This study takes z community in Nanjing as an example, and uses the interview method to collect data, it is found that the elderly living alone in the community have depression problems such as depression and anxiety, loss of interest, self-isolation and reluctance to socialize, and the needs of the elderly living alone are summarized. In this study, 20 elderly people living alone in the Z community of Nanjing were selected as the research subjects, and the mixed research method of semi-structured interviews and scale evaluation was used to systematically explore the efficacy of horticultural intervention in alleviating depression. Based on the theories of Maslow's hierarchy of needs and social support, the study designed and implemented seven thematic gardening group activities, covering the dimensions of cognitive ability, activity ability, social interaction and self-efficacy, through specific interventions such as plant identification, green plant maintenance, and community garden co-construction, the elderly living alone are guided to establish natural connections and group interactions.

The depression scale for the elderly (GDS) was used to measure the depression of the experimental group and the control group. After intervention, the depression of the experimental group showed statistically significant improvement, finally, cognitive function, social skills and self-worth were improved to a certain extent. With the help of the “ Well-being benefit evaluation form of horticultural therapy”, it is confirmed that the mechanism of horticultural therapy is reflected in the multi-dimensional synergistic effects of five-sense stimulation to delay cognitive decline, group interaction to enhance social

bonding, and skill training to improve activity ability. Finally, the process evaluation and effect evaluation of the group activities are carried out, the whole article is summarized, and suggestions are put forward, and the shortcomings of this study are reflected.

Keywords: horticultural therapy; elderly living alone; depression; group work

目 录

第一章 绪论.....	1
第一节 研究背景与研究意义	1
一、研究背景.....	1
二、研究意义.....	2
第二节 研究综述.....	4
一、国内外关于园艺疗法的相关研究.....	4
二、国内外关于独居老人抑郁情绪的相关研究	6
三、文献综评.....	13
第三节 研究设计.....	14
一、研究目的.....	14
二、研究方法.....	14
三、研究工具.....	15
四、研究思路.....	16
五、研究创新点.....	18
第二章 概念界定与理论基础	19
第一节 概念界定.....	19
一、独居老人.....	19
二、园艺疗法.....	19
三、抑郁情绪.....	20
第二节 理论基础.....	21
一、马斯洛需要层次理论.....	21
二、社会支持理论.....	22
三、注意力恢复理论.....	23
第三章 Z 社区独居老人抑郁情绪的表现及成因分析.....	25
第一节 Z 社区独居老人的状况分析	25
一、南京市 Z 社区的基本情况	25
二、南京市 Z 社区独居老人基本概况	26
第二节 Z 社区独居老人抑郁情绪的现状分析	28
一、Z 社区独居老人抑郁情绪状况调查	28
二、Z 社区独居老人的抑郁情绪的现状分析	28
第三节 Z 社区独居老人的抑郁情绪的成因分析	31
一、生理因素.....	31
二、社会环境因素.....	32
三、经济因素.....	34

第四节 Z 社区独居老人缓解抑郁情绪的需求分析	35
一、情感慰藉需求	35
二、社会支持方面的需求	36
三、人际交往方面的需求	36
四、改变偏差认知需求	37
五、自我价值实现需求	37
第五节 小组工作介入社区独居老人的抑郁情绪的必要性和可行性分析	38
一、必要性	38
二、可行性	38
第四章 小组工作介入社区独居老人抑郁情绪的实务研究	40
第一节 小组准备阶段	40
一、小组准备	40
二、小组活动设计	41
三、小组工作计划	43
第二节 园艺小组活动的展开	46
一、第一次小组活动：破冰·园艺初体验	46
二、第二次小组活动：自然之旅·百花园探秘	49
三、第三次小组活动：巧手绘园·方寸之间见自然	51
四、第四次小组活动：智慧花园·社区实践	54
五、第五次小组活动：绿色播种·报纸育苗盆制作	57
六、第六次小组活动：绿意成长·种植成果检查	60
七、第七次小组活动：园艺盛宴·社区角展示	63
第五章 小组工作介入评估	68
第一节 过程评估	68
一、小组筹备情况评估	68
二、社工表现评估	68
三、组员行为表现评估	69
第二节 结果评估	73
一、GDS 量表前后测结果分析	73
二、园艺疗法效果分析	75
三、园艺小组对于独居老人的福祉效益分析	77
第六章 总结和对策建议	80
第一节 总结	80
一、研究优势	80
二、研究局限	81
第二节 对策建议	82
一、构建跨学科协作服务机制	82

二、构建社区为本的心理健康支持生态网络	83
三、构建多方协同支持网络.....	83
四、创新本土化园艺疗愈实践形式.....	84
参考文献.....	85
附录一：半结构化访谈提纲	91
附录二：老年抑郁量表（GDS）	92
附录三：园艺疗法福祉效益评估表	94

第一章 绪论

第一节 研究背景与研究意义

一、研究背景

依据《2023 年度民政事业发展统计公报》提供的数据分析，全国范围内，年龄达到 60 岁及以上的老年人口数量已达到 2.97 亿，占据总人口比例的 21.1%。在此之中，65 岁及以上的老年人口数量为 2.1676 亿，占总人口的比重为 15.4%。^①预计“十四五”时期，我国 60 周岁及以上老年人口将超过 3 亿，占总人口比例将超过 20%，我国将进入中度老龄化社会。根据《中国家庭风险保障体系白皮书（2023）》的数据显示，拥有 60 岁及以上老年人的家庭数量，从 2010 年的 1.23 亿户增加到 2020 年的 1.74 亿户；在有一个老年人的家庭户中，老年人独自居住的比例为 21.38%。^②随着我国老龄化进程不断加快，独居老人群体日益壮大，正在成为老龄化浪潮中首当其冲的群体，他们倾向于产生焦虑、沮丧等消极情绪的困扰，整体幸福感偏低，且抑郁症状的发生率偏高。加之居住模式的特殊性，独居老人构成了老年群体中一个尤为脆弱的子群。伴随着社会的演进与家庭结构的转变，老年人独居的情形预计在未来将愈发常见，而独居老人面临的健康挑战则预示着一种难以遏制的增长趋势。

近年来，我国老年人口规模和结构呈现出基数大、速度快、趋势猛的特征，积极应对人口老龄化已经上升为国家战略。老年人群体中的独居老人引起了人们的重视。有研究发现，在城市社区，独居老年人比例约为 50%，大城市中处于空巢或独居状态的老年人达 70%以上，远远高于农村地区的 37%。^③我国改革开放以来长时间推行“计划生育”的国策，这种提倡单一子女家庭模式的社会实践，客观上重构了传统多代同堂的居住格局。随着新生代步入成年阶段，多数选择异地求学或跨区域就业，导致原生

^① 国家统计局. 2023 年民政事业发展统计公报 <https://www.mca.gov.cn/156/Z2679/index.html>

^② 中国家庭风险保障体系白皮书（2023） <https://www.sgpjbg.com/baogao/123368.html>

^③ Wong, Y. C. and Leung, J. 2012, "Long-Term Care in China: Issues and Prospects", Journal of Gerontological Social Work, Vol. 55, no. 7570-7586.

家庭结构中出现父母代际留守现象。在人口老龄化加速的背景下，老年群体中因配偶离世、婚姻关系解除或居住地分离等社会人口学变量影响，独居生活状态逐渐普遍化。在实际生活中，独居老人面临着多样化的需求，然而，相较于物质与健康需求的相对满足，他们的精神需求往往被忽视，得不到充分关注。独居老人对于风险的抵御能力极为薄弱，面对突如其来的各种状况，单凭个人之力难以有效应对，亟需外界援助，这也使得他们内心的困扰难以得到有效纾解。

随着人口老龄化的趋势日益严峻，独居老年群体的规模持续扩张，其心理健康议题逐渐浮出水面，成为亟待解决的问题。园艺疗法作为一种创新的介入策略，为缓解这一群体的抑郁情绪开辟了新途径。该疗法自引入中国以来，其应用范围不断拓展，涵盖了精神病医院、老年照护机构、儿童康复设施、各类医疗机构乃至社区和植物园等多个领域，该举措致力于增强个体的身心健康状况，并加速其康复过程。值得一提的是，我国民政部在 2015 年 10 月 23 日公布的《老年社会工作服务指南（征求意见稿）》里，正式将园艺疗法列为老年社会工作服务的一项专业技能。当前社会背景下，民众对健康生活方式的渴求日益显著，亲近自然的倾向愈发普遍。园艺疗法作为一种新兴的促进身心功能恢复的社会工作方法，为增进城市社区中独居老年人的社交交往提供了新的视角和途径。

二、研究意义

（一）理论意义

城市社区独居老年群体抑郁情绪干预是本研究聚焦的问题，且从社会工作专业视角进行了创新探索，当下国内外相关研究多集中于抗抑郁药物研发和临床诊疗技术改进方面，相比之下社会工作介入路径的理论构建与实践验证仍有明显的研究空白，本研究突破传统医学主导模式并以园艺疗法为核心构建专业干预体系，针对心理健康问题的城市社区独居老人设计实施了一系列主题园艺活动，从而把自然疗愈机制和社会支持网络创造性地有机结合起来，在研究中形成的双轨干预模型不但给老年心理问题

的非药物干预带来新思路，也对社会工作本土化实务模式的创新贡献了理论增量，进而有效弥补了该领域既有研究的系统性不足。

其次，我国在社会工作领域中对园艺疗法的研究相对较少，这是一种将园艺疗法与社会工作结合的尝试。这项研究探讨了运用园艺疗法改善城市社区独居老年人抑郁情绪的应用，不仅为一线社工提供了新的干预手段，也探索了园艺疗法在改善城市社区独居老年人抑郁情绪中的应用技能，为应对未来老龄化人口提供示范，对于缓解老龄化社会带来的问题具有重要意义。

（二）现实意义

本研究关注社会工作领域中的园艺疗法实践，其核心价值在于助力服务对象积极改善身心状态，在让服务对象亲身参与植物养护、自然观察等活动，这一干预手段给城市社区独居老人打造出特殊的心理调适空间。日常照料植物时，老年人能感受到土壤湿度变化的触觉反馈，观察植物生长还能得到视觉享受，花草的自然气息也一并相伴，多感官的协同作用于情绪改善。这种以自然要素为媒介的干预方式冲破传统医学的框架，给老年群体提供了不依赖药物的心理调适环境。在促进社会关系重构方面，园艺活动的集体属性为独居老人搭建了新型社交平台。通过参与社区花园共建、绿植养护等协作性任务，老年人在工具使用、经验交流等日常互动中逐步建立信任纽带，有效缓解情感孤立状态。

社会治理方面，该实践应对人口老龄化挑战有创新思路，把园艺疗法纳入社区养老服务体系意味着服务理念从单纯治疗疾病转变为综合开发潜能，这与国家《十四五老龄事业规划》着重强调的健康管理、精神关怀方向十分匹配，这种创新实践不但让养老服务供给形式更丰富，在推动社会文明进步上也有独特价值，为基层治理能力现代化提供了能具体操作的实践案例。

第二节 研究综述

一、国内外关于园艺疗法的相关研究

（一）园艺疗法的发展

园艺疗法具有悠久的历史沿革和持续的学科化发展过程。学术界的系统表明，园艺疗法的医学应用可追溯至古埃及文明时期。Simson 和 Straus（1998）园艺疗法的起源并非近现代产物。经考证，早期王室医疗体系已将园艺活动纳入精神调养范畴，史料记载宫廷医者通过引导贵族成员于皇家园林中系统性步行干预，以纾解情志失调之症^①。Son（2006）指出，随着医学认知的深化，该领域的发展催生了“园艺疗法”这一专业概念，其核心内涵在于通过具备资质的治疗师实施的系统性干预方案，运用植物介质及园艺操作作为治疗载体。该疗法强调治疗过程的规划性与目的性，通过结构化活动设计引导参与者建立与植物环境的多维度互动，进而实现生理机能改善与心理状态调整的双重目标^②。Park, S. A（2012）的学科史研究进一步揭示并在著作中系统梳理了该疗法的演进脉络，指出当历史进程推进至 18 世纪末至 19 世纪初叶，此类自然疗法开始获得专业医疗机构的体系化认可，逐步发展为精神卫生领域的重要干预手段，并伴随跨大西洋医学交流传播至北美地区，成为现代园艺治疗理论的重要历史源流。该疗法转型过程中，其适用范围从贵族阶层向更广泛群体拓展，专业医疗属性亦得到持续强化，为后续循证研究奠定了实践基础^③。

学者们从不同阶段划分了园艺疗法的发展历程。王玮(2015)将园艺疗法发展历程划分为三个阶段：起源期以精神疾病治疗为起点，本杰明博士和曼宁吉尔博士奠定基础；变革期转向战争伤员康复与职业培训结合；成长期建立学科体系，成立协会（NCTRH），完善教育课程，拓展医疗、养老等多元应用场景，最终确立其作为全美十

^① SimsonS, StrausMC.(1998). Horticulture as the rapy: Principles and practice.Food Products press, NY, USA.

^② SonKC, ChoMK, SongJE, KimSY, LeeSS.(2006). Practice of professional horticultural the rapy. Coobook, Seoul, Korea, pp45-46.

^③ Park, S.A., Son, K.C.Cho,W.K.(2012). Practice of horticultural the rapy in SouthKorea Authortiy culture, 179-185.

大新兴职业的专业地位^①。孙雨亮（2015）强调 18 世纪末至 19 世纪处于探索实践期，自 18 世纪后期开始，欧洲医疗体系逐步认识到植物环境干预对患者康复进程的积极影响，开始系统引入园艺活动作为治疗手段，标志着园艺疗法从自发实践向设施化、专业化过渡。至该世纪中后期，这种治疗模式的适用范围已显著扩展，尤其在针对神经发育障碍儿童及其他身心机能受限群体的临床实践中展现出独特价值，这些实践为园艺疗法在 20 世纪形成独立学科奠定了基础^②。李树华（2024）指出 20 世纪初期很长一段时间，科学家们通过报纸等媒介向普通民众宣传积极参与园艺劳动有利身心健康，但是没有形成具体的学说和理论研究成果。在 20 世纪末至 21 世纪初，随着城乡自然与健康关系认知提升，园林康养、农业康养等概念相继出现，但园艺疗法仍是专业发展程度最高的类型，研究从案例转向实证，逐步建立教育培训认证体系^③。薛滨夏（2024）结合新推出的森林园林康养师认证制度，通过医疗、社区、校园多层次机制将自发园艺活动提升至循证医学高度，激发其公共健康服务潜力，助力“健康中国”战略^④。

（二）园艺疗法的界定

园艺疗法的概念内涵持续深化，强调其系统性、多维性和专业性。李树华（2011）认为目前对园艺治疗的解释是基于美国园艺治疗协会的定义：对于需要改善身心健康的人来说，使用植物栽培和园艺实践调整心理和生理方面的有效治疗方法就可以被称为园艺治疗^⑤。随着学科发展，李树华（2022）又在其研究中阐明，现代园艺疗法是针对存在身心机能提升需求的目标群体，通过系统运用植物介质及园艺操作实践，在社会适应性重构、教育康复介入、心理调适干预及生理机能改善等维度实施综合性调整的专业干预手段。该疗法突破传统医疗手段的单一性，强调治疗过程的多维整合效应，既包含直接的身体机能锻炼价值，又通过植物环境接触间接实现情绪调节与认知功能

① 王玮,周武忠. 美国园艺疗法的发展[J]. 世界农业, 2015, (11):201-204.

② 孙雨亮. 园艺治疗起源与发展概览[J]. 广西民族大学学报, 2015, 21(4):48-54.

③ 李树华,姚亚男,孟令爽,等. 从园艺疗法到自然疗愈:类型、发展、机理与展望[J]. 风景园林, 2024, 31(05):12-22.

④ 薛滨夏,李同予,姜博. 自然疗愈体系的当代发展及公共健康服务潜力[J]. 风景园林, 2024, 31(05):23-38.

⑤ 李树华. 园艺治疗概论[M]. 北京:中国农林出版社, 2011:40-68.

改善，形成具有生态特征的整体性疗愈机制。这种多维干预框架不仅拓展了健康促进的路径选择，也为跨学科治疗协作提供了新型实践模式，其核心价值在于将自然要素的治疗潜能转化为可操作的康复方案^①。李婷婷（2023）提出，园艺疗法借助蔬菜、花卉等植物作为媒介，通过参与种植等活动，使人们亲身体验植物生命的奇妙，促成内心世界的交流，从而在生理、心理、社交及情绪层面获得益处，有效缓解焦虑与抑郁情绪^②。保拉·黛安娜·莱尔夫（2024）将园艺疗法（Horticultural Therapy, HT）定义为：在注册园艺治疗师指导下，客户通过参与培育植物、管理花园等有生命有机体的活动，以实现治疗、康复或职业目标的过程。其核心在于客户对植物生长的直接责任与互动，强调园艺活动本身作为治疗手段而非单纯休闲，结合自然元素与人类健康需求，通过行动、创造力和社会交往促进身心恢复^③。

二、国内外关于独居老人抑郁情绪的相关研究

（一）独居老人抑郁情绪表现的相关研究

独居老人的抑郁情绪表现出心理、躯体症状交织的特点，并常伴随社会支持缺失。通过质性研究分析，Chung S（2008）指出，独居老年群体在经历传统老年群体普遍面临的生存状态转变、社会角色剥离、生理机能衰退及心理健康波动等共性挑战的同时，其特殊性突出体现在社会支持网络的严重匮乏^④。薛海波（2010）的研究则揭示，老年人的抑郁情绪还可能诱发躯体化焦虑症状，诸如疼痛感、进食时恶心、胸闷等，部分患者还会经历全身性疼痛^⑤。Kim与Lee（2015）在针对老年抑郁患者的研究中，归纳了独居老人抑郁情绪的特定症状：首先，表现为情绪低落，对以往热衷的活动失去兴趣，抑郁情绪笼罩下的独居老人会持续沉浸在悲观情绪之中，以消极视角审视世

^① 李树华：园艺疗法——用自然治愈心灵[J]. 绿化与生活, 2022(09):40-43.

^② 李婷婷. 园艺治疗小组干预农村随迁父母焦虑抑郁情绪的实务研究[D]. 辽宁大学, 2023.

^③ 保拉·黛安娜·莱尔夫. 发展园艺类治疗方法理论的重要概念[J]. 风景园林, 2024, 31(05): 54-74.

^④ Chung S.residential status and depression among Korean elderly people:a comparison between residents of nursing home and those based in the community[J].Health Social Care Community, 2008,16:370-377.

^⑤ 薛海波, 张明园. 阿尔茨海默病行为和精神症状的治疗[J]. 世界临床药物, 2010, 31(07):404-409.

界，生活热情减退，动力匮乏；其次，伴有明显的躯体化症状，引发身体的不适感受^①。

量化研究进一步揭示了独居老人抑郁的多维表征及其严重负面影响。通过量化研究分析，丁泽涛（2023）运用老年抑郁量表（GDS）、正负性情绪量表（PANAS），结合前期需求调研阶段获取的城市社区独居老人心理状态特征，通过多维度干预方案设计、结构化小组工作介入及全过程效果评估的综合研究框架，论证了城市社区独居老年群体抑郁情绪的多维表征。研究结论揭示，该群体的抑郁症状呈现心理状态失衡、社会参与能力弱化及人际交往障碍的三重交互性特征，共同促进了抑郁情绪的形成。抑郁情绪带来的负面影响主要包括深度的情感痛苦、反应迟钝、生活热情缺失、食欲不振、身体机能下滑及认知能力下降，长期沉浸于此类消极情绪中，个体可能发展为抑郁症，极端情况下甚至可能导致自杀倾向，严重威胁独居老人的生命安全^②。唐彩云（2023）通过数据分析发现，农村丧偶独居老年女性的抑郁检出率为 44.0%，抑郁组在急慢性病数量、独居时间、婚姻幸福感及生活质量方面显著劣于非抑郁组，提示其抑郁情绪可能与长期身体机能衰退、慢性病困扰、社会支持缺失及生活满意度降低密切相关^③。

（二）独居老人抑郁情绪影响因素研究

健康水平，特别是生理机能衰退和睡眠问题，是影响独居老人抑郁的关键因素。Williamson&Schulz（1992）本研究针对独居老年群体抑郁情绪的生成机制进行了系统性探究，揭示生活自理能力衰退构成该群体抑郁症状的关键诱因。研究指出，随着身体机能的自然衰减，老年个体在完成基本生活任务时面临渐进性困难，这种功能性障碍不仅导致生活质量的多维度下降，更通过自我效能感削弱和生存意义感丧失的中介作用，形成自杀倾向的潜在心理通路^④。AineM（2012）选取具有代表性的老年群体样

^① Kim K, Lee M. Depressive symptoms of older adults living alone[J]. The International Journal Of Aging And Human Development, 2015, 80(3): 248-263.

^② 丁泽涛. 城市社区独居老人抑郁情绪的小组工作介入研究[D]. 四川外国语大学, 2023.

^③ 唐彩云, 黄蓉, 王瑶, 等. 农村丧偶独居老年女性抑郁、孤独感与生活质量的关系[J]. 中南大学学报(医学版), 2023, 48(12): 1865-1873.

^④ Williamson G M, Schulz R. Pain, activity restriction, and symptoms of depression among community-residing elderl

本，通过标准化心理评估工具对其情绪状态进行系统性测量，研究发现生理机能衰退程度与焦虑抑郁症状存在显著相关性。具体而言，就是在生理机能开始呈现衰退的早期阶段，老年群体已表现出明显的心理情绪困扰；随着机能衰退的持续发展，其情绪调节能力进一步受损，临床意义上的抑郁和焦虑症状出现概率显著增加^①。Luik (2015) 采用客观睡眠监测手段对老年群体睡眠质量进行系统评估，通过多维度睡眠参数分析揭示，睡眠结构完整性及节律稳定性与焦虑症状呈现显著相关性。研究指出，睡眠障碍不仅表现为睡眠时长异常，更体现在睡眠连续性中断及昼夜节律紊乱等深层特征，这些睡眠质量问题对老年群体情绪调节机制产生显著负面影响^②。

家庭环境和社会支持网络对独居老人抑郁情绪具有显著的保护或风险作用。

从家庭环境的视角出发，基于家庭生态系统理论框架，多位学者通过差异化研究路径揭示了老年群体心理健康的影响机制。李为群（2016）及其团队针对长春市老年人的焦虑状态与社会支持状况进行了调查，指出拥有高水平社会支持的老年人焦虑情绪发生率相对较低。社会支持涵盖家庭内部支持（如配偶与子女）及家庭外部支持（如朋友、邻居等），这些支持能够有效缓解不良事件对个体生理与心理的负面影响，促进心理健康的稳定^③。另外，Fatima（2019）的研究揭示，居住条件与社会支持状况对独居老人的抑郁症状具有显著影响。尽管独居本身并不必然导致抑郁情绪的产生，但当老人处于独居状态且未能保持社会交往，或是因亲友离世而导致社会支持网络削弱时，他们面临抑郁情绪的风险会显著上升^④。梁家荣（2023）创新性运用三维空间孤独感评估工具（UCLA-3 量表），对华北地区 10 位 80 岁以上空巢长者开展混合研究，其结构方程模型显示，自我效能感缺失、家庭情感扶持的匮乏以及社会支持系统的薄弱，是导

y adults[J].Journal Of Gerontology,1992,47(6):367-372.

^① AMNiMhaoláin,FanCW,Romero-Ortuno R,et al.Frailty,depression,and anxiety in later life[J].International Psychogeriatrics,2012,24(08):1265.

^② LuikAI, Zuurbier LA,Direk N,et al.24-HOUR ACTIVITY RHYTHM AND SLEEP DISTURBANCES IN DEPRESSION AND ANXIETY:A POPULATION-BASED STUDY OF MIDDLE-AGED AND OLDER PERSONS[J].Depression and Anxiety,2015:32.

^③ 李为群,张秀敏,刘莹圆,吴方园,李眩眩,刘冰,金丽娜,刘红箭.长春市社区老年人焦虑、抑郁状况与社会支持水平调查[J].医学与社会,2016,29(11):97.

^④ FatimaM,SeharA,Maha,etal.Incidence of depression among community dwelling healthy elderly and the predisposing socio-environmental factors[J].Cureus,2019,11(3):4292.

致这些老人产生孤独感的主要因素^①。

社会参与程度是缓解独居老人抑郁的重要保护因素。从社会参与来看，苏镜安（2022）指出老年人抑郁情绪表现为对活动失去兴趣、体重下降、失眠、疲劳及内疚、无价值感等负性情绪，并强调空巢状态是抑郁高发风险因素，社会参与可显著降低抑郁初始水平并减缓其上升速度，同时健康自评、年龄增长、性别、居住地等也对抑郁情绪存在影响^②。胡雪梅（2024）提到独居老人的抑郁情绪受社会参与程度影响，研究发现社会参与通过减少抑郁情绪提升生活满意度，同时性别、自评健康状况、社会照料支持和经济状况等因素也被证实与抑郁水平相关，其中缺乏社会参与、健康状况差、经济状况不佳是加剧抑郁情绪的风险因素^③。

社区居住环境，特别是文化活动，能调节居住方式对抑郁的影响。从居住环境来看，靳永爱（2017）采用 PHQ-9 量表（前 8 项）测量老年人抑郁倾向，通过多层线性模型分析，揭示社区文化活动数量对抑郁倾向有显著负向影响，且能调节居住方式与抑郁的关系：在文化活动丰富的社区，独居、夫妇同住老人与子女同住老人的抑郁得分差异缩小，独居老人抑郁得分下降最快，研究还指出慢性病、失能、经济状况等个体因素及社区低保比例、公共服务设施等环境因素对抑郁存在影响^④。

整体而言，独居老人抑郁情绪是多维度因素复杂交互作用的结果。陈丽（2017）采用老年抑郁量表(GDS)及社会支持量表(SSRS)对 204 名农村留守老人入户调查，多元逐步回归分析发现：生活来源、客观支持、居住方式、年龄、性别是影响株洲地区农村留守老人抑郁情绪的主要因素^⑤。谷利斌（2019）采用整群抽样方法选取典型城市社区独居老人进行专项研究，通过人口统计学特征描述、孤独感单因素分析以及多元线性建模等综合研究路径，发现该群体心理健康水平不容乐观，其孤独感强度主要受日常

^① 梁家荣. 个案工作介入城市高龄独居老人孤独感缓解的实务研究[D]. 广州大学, 2023.

^② 苏镜安,李岩,张敏强,等. 老年人抑郁情绪发展轨迹及社会参与的作用: 空巢与非空巢老人的对比研究[J].心理学, 2022, 45(03): 740-746.

^③ 胡雪梅, 陈庆. 社会参与对独居老人生活满意度的影响——抑郁的中介作用[J]. 中国卫生事业管理, 2024, 41(09): 1048-1051+1073.

^④ 靳永爱, 周峰, 翟振武. 居住方式对老年人心理健康的影响——社区环境的调节作用[J]. 人口学刊, 2017, 39(03): 66-77

^⑤ 陈丽, 程亮, 唐凤平. 株洲地区农村留守老人抑郁水平及影响因素[J]. 中国老年学杂志, 2017, 37(09): 2292-2294.

功能独立性、慢性病负担程度及社会支持网络密度等关键变量的显著影响。两项研究共同表明，独居老人的心理健康状态是多维因素交互作用的结果，干预策略需从生理-心理-社会多层面构建系统性支持体系^①。赵涵（2021）利用 2018 年中国健康与养老追踪调查（CHARLS）抽样调查数据，经对多因素 logistic 回归分析发现，老年人抑郁情绪表现为对活动失去兴趣、体重下降、失眠、疲劳及内疚、无价值感等负性情绪，其影响因素包括：社会参与方面，社交活动、体育锻炼是保护因素，农业劳动是风险因素，工作满意度高可降低风险；家庭交往方面，对配偶和子女满意度高、与子女同住或频繁互动可显著降低抑郁风险，而低满意度或交往频率低则会增加风险^②。张云秋（2022）基于大规模独居老年群体样本调查，运用卡方检验及二元逻辑回归模型开展心理健康影响因素研究，指出我国独居老年群体存在较高的亚临床抑郁风险，其核心影响因素涵盖代际支持频率、经济基础稳定性、体育参与程度、躯体健康水平及主观生活质量评价^③。

（三）关于园艺疗法介入抑郁情绪的研究

大量实证研究证实园艺疗法能有效改善抑郁情绪，并在生理指标上呈现积极变化。基于生态心理学理论框架，多学科实证研究揭示了园艺干预对特殊群体心理健康的促进机制。在生理指标层面，早先，GoZZaleZ、Hartig 及 Patil（2011）等学者基于临床实践观察，创新性地提出园艺干预对抑郁障碍患者的治疗价值。其研究发现，通过系统设计的植物养护、自然景观体验等园艺活动，患者不仅实现了症状学层面的显著改善，更在存在主义维度展现出积极变化。具体表现为，园艺活动作为治疗性媒介，有效促进了患者对生命意义的再发现与价值重构，进而提升了整体生活质量^④，这

^① 谷利斌,徐德国,何贵蓉,等.社区独居老人孤独现状和相关影响因素的调查[J].南京中医药大学学报(社会科学版),2019,20(02):112-116.

^② 赵涵,向远,裴丽君.老年人多维度社会参与和家庭交往与抑郁情绪发生风险的关联研究[J].人口与发展,2021,27(03):110-122.

^③ 张云秋,张先庚,曹冰,等.基于 CLHLS 的我国独居老人阈下抑郁现状及影响因素研究[J].循证护理,2022,8(08):1068-1071.

^④ Gonzalez.Hartig.&Patil.A prospective study of group cohesiveness in therapeutic horticulture for clinical depression[J].International journal of mental health nursing,2011:119-129.

一发现与 OhYA (2018) 的阶梯式干预研究形成呼应, 该研究经 10 周植物艺术创作干预后, 实验组 SCL-90 量表的阳性症状均分降幅达 22.4%^①。韩国学者 HaZ (2018) 的随机对照试验显示, 实施系统性园艺疗法后, 实验组老年受试者的血清皮质醇浓度显著降低, 同时心率变异系数提升, 证实植物互动疗法对老年焦虑状态的缓解效应^②。

园艺疗法在缓解焦虑、疼痛和改善情绪方面显示出即时和短期效果。此外, 在作用时效性研究方面, erraML、FAZgst 等人 (2012) 采用分组对照研究设计, 将慢性肌肉骨骼疼痛患者随机分为实验组与对照组, 系统考察了园艺治疗在疼痛管理中的整合应用效果。研究结果显示, 接受园艺干预的实验组在身心整体健康状态改善方面表现出显著优势, 具体体现为焦虑症状的有效缓解及疼痛应对能力的提升^③。Lec 等研究者 (2013) 深化了园艺干预的情绪调节效应研究, 通过结构化实验设计发现, 在参与中等时长的园艺活动干预后, 受试群体在情绪效价维度表现出显著提升。研究还额外揭示, 室内园艺活动对于减轻人类压力同样具有显著效果, 证实短期园艺接触具有即时压力缓冲功能^④。KyuZg 等人 (2018) 通过种植植物、制作植物工艺品及插花等活动, 相较于对照组, 实验组的抑郁与焦虑程度显著降低^⑤。

针对老年群体的园艺疗法干预能显著改善其身心健康、社会功能及主观幸福感。基于生态心理学的压力缓冲模型, 近年纵向研究持续验证植物互动干预对特殊老年群体的心理健康增益效应。周炼 (2019) 构建了结构化园艺干预方案, 针对心理空巢老年群体实施团体治疗项目, 重点探究园艺活动对该群体焦虑抑郁症状的调节作用。通过多阶段园艺干预课程的开展, 老年参与者完成了系统化的治疗计划。为科学评估干预效果, 研究采用标准化心理测评工具, 包括抑郁自评量表 (SDS)、焦虑自评量表 (SAS)

^① OhYA, ParkSA, AhnBE. Assessment of the psychopathological effects of a horticultural therapy program in patients with schizophrenia[J]. Complementary Therapies in Medicine, 2018, 36: 54-58.

^② HanAR, ParkSA, AhnBE. Reduced stress and improves physical functional ability in elderly with mental health problems following a horticultural therapy program[J]. Complementary Therapies in Medicine, 2018.

^③ VerraML, FAngst, BeckT, et al. Horticultural therapy for patients with chronic musculoskeletal pain: results of a pilot study[J]. Altern Ther Health Med, 2012, 18(2): 44-50.

^④ Min-sunLee, Bum-jinPark, JuyoungLee, et al. Physiological relaxation induced by horticultural activity: transplanting work using flowering plants[J]. Journal of Physiological Anthropology, 2013, 32(1): 1-5.

^⑤ Kyung-HeeK, Sin-AeP. Horticultural therapy program for middle-aged women's depression, anxiety, and self-identify[J]. Complementary Therapies in Medicine, 2018, 39: 154-150.

及活动满意度问卷，分别在干预前后实施数据采集与对比分析。研究证据表明，园艺干预在促进老年参与者身心健康方面展现出多维改善效应：生理健康指标呈现积极变化趋势，负性情绪强度显著降低，社会交往功能得到有效恢复^①。李树华黄秋韵（2020）实施的多样化植物互动干预显示，独居老年群体经 12 周系统性干预后，实验观测数据显示，接受系统性园艺干预的老年群体在多个心理健康维度呈现显著正向变化。具体而言，其功能性生活自理能力得到有效维持，自我评价水平显著提升，同时主观幸福体验也表现出积极改善，证实自然要素接触具有多维度的身心调节功能^②。魏钰（2020）通过对比播种、间苗、多肉组合盆栽与草花组合盆栽四种园艺活动，采用正负性情绪量表、笑脸量表及心率变异性（HRV）等生理指标，通过配对 t 检验和单因素方差分析发现，播种和间苗活动在缓解生理压力、提升情绪状态方面具有显著优势，但 4 次短期干预未显著改善长期身心健康自评与幸福感^③。在代际压力干预领域，李婷婷（2023）采用标准化实验流程，对 8 例存在焦虑抑郁症状的农村随迁父母实施结构式干预方案。经 6 周植物栽培治疗，汉密尔顿焦虑量表评分下降，抑郁自评量表得分降，家庭支持感知量表提，提示植物互动具有情绪疏导与家庭关系重建双重效能^④。

园艺疗法在老年慢性病患者群体中也展现出积极效果，其作用机制研究逐步深入。在针对慢性病老年患者的治疗研究中，杨翎（2019）从园艺治疗的角度出发，以问卷调查数据为基础，采用了覆盖面较广的小组工作方法。研究立足于 ReIf 的负荷-唤起理论模型，创新性融合心理发展理论与文化学习理论的核心要义，构建了多维理论框架指导下的园艺干预方案。方案以老年慢性病患者为目标群体，通过园艺治疗活动的系统实施，首先针对焦虑症状进行针对性缓解，继而通过情绪调节机制的激活促进整体心理状态的正向转变，干预设计着重强化情感支持网络的重建，通过团体互动形式满足老年患者的社会交往需求，同时促进情感表达渠道的拓展。最终干预目标指

^①周炼. 园艺治疗小组活动缓解心理空巢老人焦虑抑郁情绪的干预研究[D]. 西南财经大学, 2019.

^② 李树华, 黄秋韵. 基于老人身心健康指标定量测量的园艺活动干预功效研究综述[J]. 西北大学学报(自然科学版), 2020, 50 (06) :852-866.

^③ 魏钰,董知洋,虞雯,等. 四种不同园艺疗法活动对孤寡老人的身心健康效益研究[J]. 西北大学学报(自然科学版), 2020, 50 (06) :923-933.

^④ 李婷婷. 园艺治疗小组干预农村随迁父母焦虑抑郁情绪的实务研究[D]. 辽宁大学, 2023.

向生理指标的稳定与心理韧性的提升,使患者能够建立更为积极的疾病应对模式^①。郭云飞与张振香(2020)学者针对脑卒中患者采纳了康复花园疗法。通过设立对照组实验,他们在介入过程中验证了园艺治疗对于维持患者积极心态、提升生活质量及加速身体康复的积极作用^②。在作用机制方面,李树华(2024)揭示了自然疗愈的双重路径:一是通过视觉、听觉等感官刺激调节自主神经系统的SDNN值(心率变异性指标),改善情绪状态;二是通过暴露于芬多精等自然有效成分,增强自然杀伤细胞活性,提升免疫功能^③。

三、文献综评

国内外相关文献研究回顾梳理后就能发现,园艺疗法介入独居老人抑郁情绪方面的研究主要集中在以下几个方面:

研究背景分析可知,西方很早就开始了园艺疗法有效性探索并广泛应用研究成果于多个领域且相关文献数量不少,而国内园艺疗法研究和本土化才刚起步。

从研究视角来看,园艺疗法受众范围窄些,在独居老人身心调节、家庭关系改善以及弱势群体再就业等方面的应用还不够,并且它在社会工作领域渗透得也不广,虽然康复花园这类景观设计是其重点关注对象,但在社会工作实务里的应用窄呢,跟社会工作实践深度融合的情况少。

在研究问题方面,学者间的理解有差异,大多数学者觉得独居老人抑郁情绪是长期缺少情感关怀所致,会表现出不适应感、孤独感,并且身体有疾病加上家庭情感支持不够也会产生负面情绪。

从研究方法的角度看,用园艺疗法小组来研究独居老人抑郁情绪的情况并不常见,并且经文献回顾可知,在城市社区独居老人抑郁情绪的实务研究中,虽然社会工作专业方法被应用,但很少有人对干预策略和介入过程进行系统性的经验总结。

^①杨翎.“园艺疗法”视角下老年慢病患者焦虑情绪的介入研究[D].吉林大学,2019.

^②郭云飞,张振香,林蓓蕾,刘清玄,梅永霞.康复花园疗法在脑卒中患者康复中的应用进展[J].解放军护理杂志,2020,37(04):78-79+86.

^③李树华,姚亚男,孟令爽,等.从园艺疗法到自然疗愈:类型、发展、机理与展望[J].风景园林,2024,31(05):12-22.

园艺疗法被本研究重点关注其作为社会干预措施的路径，本研究把园艺疗法和社会工作实践以团队合作形式相融合，目的在于让城市社区独居老年人在社会互动、活动能力和自我效能感等方面得到提高从而改善生活质量并减轻抑郁情绪，本研究想给未来针对城市社区独居老年人的社会干预研究提供宝贵思路和指导。

第三节 研究设计

一、研究目的

本研究的宗旨在于探讨 Z 社区独居老年人抑郁情绪的现状，剖析导致独居老人抑郁情绪产生的根源，本研究聚焦于验证园艺疗法在城市社区独居老年人抑郁情绪缓解中的应用效果。秉持社会工作的基本价值理念，并运用其相关理论方法与实务技巧，本研究设计了以园艺活动为媒介的小组工作干预方案。该方案旨在通过针对性的活动安排，有效降低目标老年群体的抑郁症状程度，充盈其精神文化生活的内涵，协助建立稳固的互助支持体系，进而促进他们与社区及社会环境的良性互动与深度融合。

二、研究方法

（一）文献研究法

本项研究开展之前，笔者系统地梳理了独居老年群体心理健康领域以及园艺干预方法相关的学术成果，通过系统检索国内外相关学术文献并深入研读，重点关注老年群体抑郁心理问题研究成果且全面考察园艺辅助干预手段，在系统整理现有学术成果后进一步梳理老年抑郁情绪的病理特征和社会影响因素，深入探讨园艺疗法在心理健康促进领域的应用价值，这一文献整合过程给本研究的理论框架构建和实证分析打下了坚实基础。

（二）访谈法

本研究采用半结构式访谈作为主要数据收集方法，其有着灵活的对话框架且具有很强的情境适应能力，所以在访谈时研究者能依据对话进展情况动态调整。在设计干预方案的时候，研究者深入地对目标社区独居老人、养老服务站工作人员以及街道社工开展系统的深度质性访谈，以便全面掌握这个群体抑郁心理的多元表征和服务需求的深层结构。进入到小组干预实施阶段后，研究者继续运用访谈法，通过采访老年参与者、活动组织者和志愿者等多方面主体，知晓独居老年群体在干预中的即时体验、情感回馈以及行为变化。

（三）量表法

量表法是心理学领域内采用标准化测量工具对心理干预成效进行客观验证的方法。在本研究里考虑到社区独居老年人身心特点依据社会支持理论开发出结构化园艺干预方案，该方案有七个园艺主题小组活动单元且这七个单元层次递进、时长设为 45 到 60 分钟，并且这一方案围绕园艺疗法四大核心功能从生理健康、心理状态和社会互动这三个方面综合发力以减轻城市社区独居老人抑郁症状，为了系统量化干预效果研究人员采用了老年抑郁量表（GDS）、简易精神状态检查量表（MMSE）还有园艺疗法福祉效益问卷这些标准化工具，在活动开始前和结束后分别对实验组和对照组参与者相关指标进行测量并做统计分析。

三、研究工具

（一）抑郁自评量表

老年抑郁量表（Geriatric Depression Scale，简称 GDS）由 BrinkTL 及其研究团队在 1982 年开发，专门用于筛查老年群体中的抑郁状况，它是一种自评式问卷，借助 30 个结构化条目能系统地评估受试者最近一周的心理状态，像情绪体验（包括心境低

落)、行为特征(例如兴趣减退)、认知模式(含消极思维)、躯体化表现这些核心维度都涵盖其中,并且它的“是/否”这种独特的二选一应答模式让老年群体理解起来比较容易。

本研究采用国际通行的三级划分标准,即量表总分 0-10 分视为心理健康状态,11-20 分表明有轻度抑郁倾向,21 分及以上显示存在中重度抑郁风险,这一分级体系给老年人抑郁情绪筛查提供量化依据,可作研究对象筛选的分层标准与干预效果的评价工具,对比干预前后量表得分的统计学差异就能客观体现小组工作模式对特殊群体心理健康状况的干预效能。

(二) 园艺疗法福祉效益评估表

世界卫生组织(WHO)提出健康五维度理论,包括生理健康、情绪稳定、认知清晰、经济保障和社会适应这五个方面,园艺疗法福祉效益评估工具就是依据这一理论构建起来的标准化测量工具,2012 年台湾学者郭毓仁和陈慧娟联手开发了这个量表且其条目设计采用积极陈述形式,能够从 8 个维度系统地评估个体参与园艺干预前后健康改善的效果。所谓园艺疗法的“福祉效益”,即个体参与园艺活动后在生理、心理、社交、认知和经济五个维度所获的综合健康提升与生活质量改善,这一概念凸显园艺疗法不光着眼于疾病治疗,更重要的是推动人的整体幸福感和生命质量的提升。

在量表编制时,研究者整合国际心理健康领域成熟量表的测量框架,最终形成含 8 项条目的评估体系,其中各条目用李克特五级评分法,选项从“完全不同意”到“完全同意”是梯度响应,单项得分在 1-5 分之间且总分范围为 8-40 分,台湾地区心理咨询师和医疗社工被研究团队用来做实证研究以验证这个工具信度和效度较好,其评估机制主要是干预前后对比分析法,总分提升幅度越大或者单项得分变化值越高就说明受试者在对应维度的福祉效益提升越明显。

四、研究思路

前期,在研究初期,研究者在 Z 社区进行了实地观察,通过与社区内老年人的日

常对话及行为观察记录，发现多数老人处于独居状态，缺乏亲友及同龄人的社交支持，情绪上表现出压抑状态。基于此发现，研究者深入查阅了国内外关于独居老人抑郁状况的文献资料，并选用了老年抑郁量表（GDS）、访谈及观察作为评估工具，对社区内部分独居老人的心理状态进行了测量，以分析和评估他们缓解抑郁情绪的需求。特别把 GDS 得分介于 11 至 20 分之间的独居老人确定为服务对象，并引导他们参与小组活动。在小组介入前，研究者通过两次数据结果的描述性统计与 T 检验分析，确保了研究的有效性和准确性。

随后，结合园艺疗法的特性与小组工作的专业方法，以马斯洛需求层次理论、社会支持理论为理论框架，从认知水平、活动能力、社会交往及自我效能感四个维度设计了为期七周的园艺治疗小组活动方案。方案的实施严格遵循了既定的园艺活动规划。在小组活动首次开展前及最后一次结束后，研究者分别进行了量表的前测与后测，并详细记录了每次小组活动的具体情况。之后，对收集到的量化数据和质性资料进行了系统整理与深入分析，从而提炼出研究的核心发现。

研究后期，小组活动完结后依据活动过程中积累的观察数据，对小组的整个过程及其成效展开了系统性评估。进而，深入分析了本次实践研究中显现的不足，并有针对性地策划了优化措施。研究思路如下图所示：

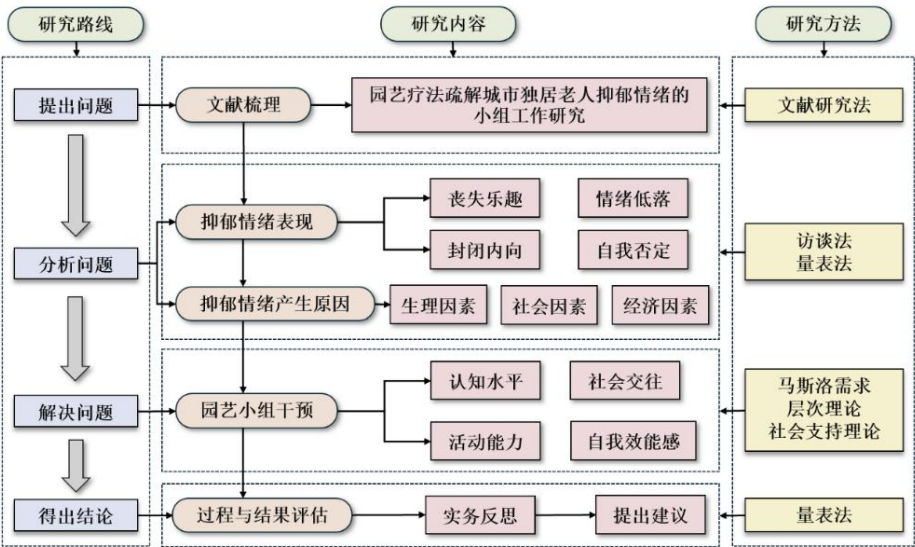


图 1-1 技术路线图

五、研究创新点

其一，理论层面将园艺疗法与马斯洛需求层次理论和社会支持理论有机融合，突破传统医学模式对“身心二元论”的依赖，通过植物生命周期观察、土壤触觉体验等无感感官刺激手段，验证了自然要素对老年群体情绪调节的独特价值。

其二，小组活动创新性设计了七阶段渐进式干预路径，从破冰体验与植物初识、自然五感探索、卡片花园实践、成果展示等环节形成完整闭环。同时，开发出废报纸育苗盆制作、社区花园共建等低成本活动载体，更好的链接社区内资源，缓解城市社区养老资源短缺的现实困境。

第二章 概念界定与理论基础

第一节 概念界定

一、独居老人

当前，关于独居老人的界定尚未形成统一共识，学界对此持有各异见解。赵立新（2024）界定独居老人为“单独居住的老年人”，具体涵盖三类情形：一是终身未婚而独居的老年人；二是无子女且因丧偶或离异而独居的老年人；三是虽有子女但子女不在身旁且没有配偶陪伴的空巢老年人。^①杨阳（2023）界定独居老人为年龄达到或超过 60 岁，处于丧偶、分居、离异或未婚状态，且子女不在身旁或缺乏其他照料者陪伴，从而独自生活的老年人群体。^②陈亨飞（2023）将那些因家庭结构变化、子女长期外出、配偶去世、无子女等特定因素而被迫独自居住生活的老年人，定义为“独居老人”。^③张良礼（2006）提出年龄在 60 岁和 60 岁以上的独自一个人生活的人被称之为独居老人。^④综合多位学者的见解，笔者认为，独居老人是指那些长期处于独自居住状态，缺乏子女及其他亲属陪伴的群体。导致老年人独居的主要因素涵盖子女离家、丧偶、离异以及分居等。在本研究中，城市社区独居老人特指年龄超过 60 岁，居住在城市社区内，因离异、丧偶等原因未与配偶、亲属或他人共同生活，独自居住或无子女的老年人。

二、园艺疗法

园艺疗法（Horticultural Therapy）作为一种专业干预手段，由具备资质的治疗师引导存在身心改善需求的个体参与系统性园艺实践，通过植物栽培与养护过程实现

^①赵立新. 独居老人居家安全的社会协同机制研究[J]. 人口学刊, 2024, 46(04): 86-98.

^② 杨阳. 积极情绪对社区独居老年人自杀意念的保护作用及干预研究[D]. 山东大学, 2023.

^③ 陈亨飞. 小组工作介入独居老人智能手机使用能力提升研究[D]. 西北民族大学, 2023.

^④ 张良礼. 应对人口老龄化——社会化养老服务体系构建及规划[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2006: 201.

生理机能、心理状态、社会适应及认知能力等多维度的改善。^①该疗法在理论体系构建中呈现广义与狭义之分：狭义范畴特指针对特定康复对象设计的结构化园艺治疗方案；而广义层面则涵盖所有通过植物相关活动促进身心健康和精神恢复的辅助性干预措施，如芳香疗法、景观疗法、森林康养以及色彩疗法等多元化形式，其适用人群覆盖不同健康状态的社会群体。^②李婷婷（2023）提出的园艺治疗模式，是以栽培活动为载体构建的心理干预机制。其作用机理在于引导参与者在植物生长周期中建立与自然生命的互动联结，通过系统性园艺操作实现多维效益的协同作用。^③在本研究中，参照国际权威机构提出的植物辅助干预操作框架，构建以生态互动为核心的团体干预模式，该模式依托生命体与非生命体构成的生态媒介，通过系统性设计的多维介入路径，引导参与者实现整体性健康促进。老年群体在参与园艺活动的过程中，促使老年群体经由视觉辨识、触觉反馈及嗅觉刺激等完成与植物的深度交互。这种整合路径，着力于通过四个维度的功能重建：认知激活层面，活动参与层面，自我效能感层面，社会连结层面培育互助型支持网络。其内在机制在于利用自然元素的隐喻特性，构建替代性情感表达场域，从而有效缓解老年群体的负性心理状态。

三、抑郁情绪

Mustaffa 等人(2014)抑郁情绪属于普遍存在的心理亚健康现象，其核心特征包括持久性情绪低落状态、愉悦体验能力下降、认知动能减弱以及自我价值感降低等临床表现，这种心理困扰若持续存在，可能导致个体出现显著的社会功能损害，具体表现为学业效能下降、职业表现失常及日常生活质量受损等多维度负面影响。^④冉梦洁（2023）将抑郁情绪界定为以情感低落为核心特征的心理状态，具体表现为情绪消沉、愉悦感缺失及悲观体验增强。该心理现象具有短期存在的特点，通常不超过两周，其发生多

^① 邵宇,田小莎,赵鹏飞.园艺疗法在生态旅游中的营造[J].黑龙江农业科学,2013(01):84-85+100.

^② 姜立杰. 园艺疗法在儿童康复中心公共空间中的应用研究[D]. 山东建筑大学, 2023.

^③ 李婷婷. 园艺治疗小组干预农村随迁父母焦虑抑郁情绪的实务研究[D]. 辽宁大学, 2023.

^④ Mustaffa,S.,Aziz,R., Mahmood,M.Z.,&Shuib,S.Depression and Suicidal Ideation among University Students. Procedia-Social and Behavioral Sciences,2014,116(1),4205-4208.

与特定负性生活事件存在明确关联性。研究显示此类情绪反应虽会引起主观不适感，但个体仍能维持基本社会功能，对工作学习效率的影响程度多处于可控范围。^①王暖怡（2023）则着重强调抑郁情绪的可调节性特征，认为这是存在于正常心理波动阈限内的适应性反应，其持续时间具有自限性特点。^②

本研究将抑郁情绪的考察范围限定于未达到临床诊断标准，特指那些表现为表层负面情绪反应但尚未构成医学诊断病例的心理状态。具体而言，本研究聚焦于非病理化的日常抑郁情绪体验，仅探讨其作为心理亚健康状态的情绪表征，而不涉及需要专业医疗干预的抑郁症确诊群体。研究重点聚焦城市社区独居老年群体中，由多维需求失衡引发的情绪困扰现象，表现为个体情绪消沉、焦虑、兴趣降低、封闭自己与不愿活动等，并根据老年抑郁量表（GDS）评分标准，将得分在 11-25 分之间的独居老人定义为有抑郁情绪的独居老人。

第二节 理论基础

一、马斯洛需要层次理论

亚伯拉罕·马斯洛（Abraham Maslow）作为美国心理学家，在 1943 年出版的著作《人类动机理论》中首次提出了需求层次理论。该理论的核心框架认为，人类的需求呈现为一种递进的层级结构，由低至高依次包括：基础生理需要、安全需要、社交与爱的需要（归属感与情感满足）、尊重的需要以及最高层级的自我实现需要。具体而言，基础生理需要涉及生存必需的元素，例如食物、水、氧气、休息以及繁衍本能等保障个体存续的基本条件。安全需要则涵盖了个体对环境稳定性的追求，诸如人身安全、住所庇护、健康状况以及经济保障等维度。社交需求指与他人建立联系、获得爱和归属感的需求，如友谊、家庭关系、社交活动等。尊重需求包括获得他人尊重、自尊心的满足，以及获得成就感和认同的需求。自我实现需求是最高级别的需求层次，指个体激发自己的潜能和实现自己的目标，通过发展个人才能、追求个人目标和对于生命

^① 冉梦洁. 消极父母教养方式对中职生抑郁情绪的影响：领悟社会支持和心理僵化的作用[D]. 西南大学, 2023.

^② 王暖怡. 失能老人家庭照顾者抑郁情绪缓解的个案工作介入研究[D]. 长春工业大学, 2023.

的意义等来实现，强调个体行为动机由未满足的需求驱动，且需求满足具有逐级递进的规律性。

从理论层面解析，个体内部普遍存在五种不同层级的潜在需要，但在特定阶段呈现出的主导性需要存在显著差异。个体当前最为迫切的愿望，通常构成其行为动机的核心驱动力。随着发展进程，人们的满足来源经历从外部依赖性到内在自主性的转变过程。当较低层级需要获得基本满足后，其激励效力逐渐弱化，主导地位随之转移，更高层级的需要则成为新的行为推动要素。某些需要一旦实现便丧失驱动力，随即被其他需要所替代。相较之下，更高层级的需要蕴含更大价值空间。高层次需要能激发出更持久的行为热忱。自我实现作为人类终极追求，体现为以最高效且完整的方式释放自身潜能，这种状态使人获得高峰体验的终极满足。

该理论突破了传统行为主义单纯强调外部刺激的局限，将人的主体性需求置于心理学研究的核心，为理解人类行为动机提供了系统性框架，被誉为“人本主义心理学基石”。其影响跨越心理学、教育学、管理学等多学科领域，尤其在社会工作实践中被广泛用于需求评估与干预策略设计。当应用于老年群体时，该理论揭示了抑郁情绪的多维成因。在本研究中，研究将理论转化为三个干预维度：基础层聚焦生理与安全需求的补偿，通过绿植养护活动重建生活秩序感；中间层着力满足社交与尊重需求，借助社区花园共建促进代际协作，设置成果展示环节激发价值认同；顶层关注自我实现需求，通过植物生长周期的见证提升自我效能感，为老年心理健康干预提供了需求导向的实践范式。

二、社会支持理论

社会支持作为多学科研究领域的核心变量，其概念界定始终存在多元理解视角。不同学科之间乃至同一领域内，研究者们尚未就此形成统一的理论共识。该概念最早可溯源至社区心理学及流行病学研究，Cassel 与 Cobb 等学者将其视为个体面临压力时影响身心健康的中介机制。他们发现社会支持能有效调和压力对身心状态产生的负面

作用^①。随着社会网络分析的出现，社会支持的实证研究被大大推动，衍生出了一些更为精细的理论和测量工具，使研究者对于社会支持的了解更为深入^②。

社会支持理论（Social Support Theory）是一种解释人际关系和社会网络如何通过提供情感、信息和实际帮助，缓解个体压力、提升心理和生理健康的理论。社会支持概念可从两个维度阐释：功能维度指向个体通过社会关系网络获取的物质资本、经济资源及精神援助；操作维度则强调支持主体与受体间的互动关系。依据支持来源的性质，学界普遍将其区分为制度化与非制度化两种类型。前者指政府行政部门（如各级社会保障机构）、法定组织（工会、共青团等）实施的规范性支持；后者则源自家庭、亲友及非正式社交网络的扶持行为。

从内容构成分析，社会支持涵盖社区网络与亲密关系所实际提供及主观感知的双重支持形态，具体包含：工具性支持表现为行动指引、事务协助、资源供给与问题解决策略；表达性支持涉及心理疏导、情绪安抚、价值认同及情感回应等非物质性援助。

本研究采用社会支持理论指导园艺疗法干预方案的设计与实施。社区养老服务中心作为正式支持主体，提供场地、社工指导及基础物资，通过园艺活动搭建社会支持平台。在七次活动中，促进独居老人沟通，强化其社区归属感。非正式支持则通过小组内部互动实现，促使组员自发形成互助关系，弥补家庭情感支持的缺失。研究兼顾工具性支持与表达性支持，社工先通过激发种植技能和实操，再为老人创造获得社会认可的机会。园艺活动本身成为连接正式与非正式支持的纽带，既整合社区资源，又激发组员间的情感联结，通过加强社会联结、增强归属认同等路径缓解抑郁情绪。这种多维支持网络的构建，印证了社会支持理论在改善老年心理健康中的实践价值。

三. 注意力恢复理论

在园艺疗法的理论体系中，注意力恢复理论（Attention Restoration Theory, ART）提供了一个关键的解释框架，用以阐明自然环境与园艺活动如何有效缓解心理压力并

^① Kaplan, B. H., Cassel, J. C., & Gore, S.. Social support and health [J]. Medical Care, 1997, 15(Suppl 5), 47-61

^② Cobb S. Presidential Address-1976. Social support as a moderator of life stress[J]. Psychosomatic medicine(5), 1976, 23

改善情绪状态。该理论由环境心理学家 Rachel Kaplan 和 Stephen Kaplan 于 20 世纪 80 年代系统提出，核心观点认为人类具备两种注意力模式：指向性注意力需要意志努力维持且易疲劳，而自然环境中的柔和刺激能自发引导注意力，使疲劳的认知资源得到修复。后续研究证实自然环境通过提供远离日常压力的空间、给予延展性认知体验、创造兼容个体兴趣的探索机会以及培养场所归属感四个维度，促进心理疲劳恢复和积极情绪生成。在本研究中，该理论具体应用于四个关键环节：百花园探秘活动引导老人沉浸于植物形态与气息的观察，实现注意力的自发吸引；育苗盆制作过程通过手工操作形成心流体验，帮助脱离日常烦忧；社区花园修剪实践创造开放性探索空间，促进认知灵活性重建；绿植养护日记则强化生命联结感，培育持续性的情感寄托。这种结构化设计使独居老人在低心理负荷状态下重建认知平衡，为缓解抑郁情绪提供了神经心理学的解释路径，与五感刺激、技能训练等干预手段形成多维度协同效应。

第三章 Z 社区独居老人抑郁情绪的表现及成因分析

第一节 Z 社区独居老人的状况分析

一、南京市 Z 社区的基本情况

南京市 Z 社区成立于 2009 年，是整个片区最早建成的保障房小区，也是全国示范性老年友好型社区之一的社区，占地 37.2 万平方米，总建筑面积 62 万平方米，共有四个园区 45 栋楼，共有 5948 套住房。目前整个社区人口入住率在 70%以上，已登记 4200 余户，约 1.3 万人，其中常住人口近 7000 人，流动人口 6000 多人，党支部现在册党员 95 人。该社区人口老龄化结构较为明显，60 周岁以上老年人口有 2600 多名，80 周岁以上老年人 300 多人，其中独居老人 130 多户，特困老人 13 户，是典型老年人居多的社区。

同时，社区在 2016 年建设了一家居家养老服务中心，面积 300 平方米，投资 30 多万元，为积极应对人口老龄化国家战略，发展养老事业和养老产业，改变养老服务中心环境老旧、配套设施老化等问题，Z 社区在 2023 年将养老服务中心改造工程列入重点项目和民生实事，投入大量人力、物力、财力对总高 4 层的社区党群服务中心进行全面改造，经实地调研发现，该养老服务机构通过垂直整合服务体系构建了复合型养老生态圈。首层空间规划为在地化生活支持单元，设置日常文娱活动区与基础生活支持模块，涵盖身心康护、日间综合照护等适老化服务集群。次层空间定位为社会组织协同创新平台，常态化开展文化浸润项目与社区教育课程，形成代际融合的公共参与场域。第三功能层作为基层治理服务枢纽，构建民生事务集约化办理机制，精准定位助餐、助乐、助浴、助医等居家养老化服务项目，实现老年人“就地、就近、就亲、就熟、就便”的便捷性。

整体来看，该社区的基础设施与服务能够满足社区内居民的一般需求。社区广场面积广阔，并设有很多健身器材，其次在今年的社区改造中，对小区环境再一次做出崭新升级，种植大量绿植花卉，彩绘社区墙面，当前社区公共服务设施在基础功能供给层面已达到适老性标准，但在针对性服务供给层面存在结构性缺失。虽然公共活动空间的物理可达性与安全性能满足老年群体的日常行为需求，但针对独居老年亚群体的介入性活动设计明显不足。受限于身心机能衰退、社会支持网络薄弱等个体化因素，该群体普遍面临参与动能不足与活动适配性障碍的双重困境。

二、南京市 Z 社区独居老人基本概况

通过在实习过程中对这些独居老人的走访调研及电访，笔者了解到有很大一部分老人存在轻度的抑郁情绪问题, 缺少同辈交流，有时候会出现较多负性情绪。笔者有针对性向 Z 社区中的独居老人发放了 130 份问卷，因其中三人有严重的听力障碍，有 2 人是因为常住在老家农村，所以最终收取有效问卷 125 份。问卷主要包括独居老人的基本信息、健康状况、独居原因、经济情况和社交状况等方面的内容。具体如下表所示。

表是 Z 社区独居老人基本情况的统计，具体分析如下：

表 3-1 Z 社区独居老人的基本信息

变量	类别	人数	比例
性别	女	81	64.8%
	男	44	35.2%
	总计	125	100%
年龄	60-70 岁	52	41.6%
	70-80 岁	45	36.0%
	80 岁以上	28	22.4%
民族	汉族	120	96.0%
	其他	5	4.0%
文化水平	从未上过学	27	21.6%
	小学	56	44.8%
	初中	31	24.8%
	高中及以上	11	8.8%
独居原因	子女外出且丧偶	105	84.0%
	无配偶无子女	20	16.0%

独居时长	5 年以下	53	42.4%
	5-10 年	47	37.6%
	10 年以上	25	20.0%
健康状态	较健康	29	23.2%
	有基础疾病或慢性疾病	96	76.8%
史			
养老保险	有	110	88.0%
	无	15	12.0%
医疗保险	有	113	90.4%
	无	12	9.6%

从性别组成来看，女性比例 64.8%，而男性为 35.2%，在独居老人中，女性更加容易独居，女性患抑郁情绪的风险也比男性大。

从独居现状特征看，绝大多数因子女外出独居（84%），反映空巢老人问题突出；独居时长集中于 5 年及以下（42.4%）与 5-10 年（37.6%），表明近半数老人处于独居适应关键期。值得注意的是，16%因无配偶无子女独居，这类群体社会支持网络更为薄弱

从健康状态来看，完全健康并且任何疾病史的仅有 29 人，占比 23.2%，有基础疾病或慢性疾病史的占比 76.8%，由此可知，Z 社区独居老人大多都可以自理并且完全独立参加社区活动。通过实地调研及与社区工作人员访谈发现，该区域独居老年群体普遍存在社会关系网络薄弱现象。该群体多源于周边村镇的迁移安置，原有地缘关系断裂后未能建立新型社交联结，社区内部缺乏有效的互动载体与沟通机制。

从老年保险来看，大多数独居老人都拥有养老保险和医疗保险，且 Z 社区独居老人的医保覆盖率更大，达到 88.0%，因此，在 Z 社区独居老人就医上面能够得到一定的保证。

综上所述，Z 社区独居老人的整体特征为：数据呈现“三低一高”特征：文化水平低、社会支持低、民族多样性低，高龄化程度高。建议优先关注女性、低学历及长期独居群体，通过邻里互助、代际互动等形式构建支持系统；针对高龄老人开发适老化园艺工具，结合方言沟通降低服务门槛。

第二节 Z 社区独居老人抑郁情绪的现状分析

一、Z 社区独居老人抑郁情绪状况调查

基于前期开展的社区实地调研与数据采集工作，研究发现 Z 社区独居老年群体普遍存在不同程度的抑郁倾向。为系统且量化评估该群体的心理状态特征，本研究采用标准化心理测量工具老年抑郁量表进行分析。

在社区独居老年群体中，部分研究对象因受教育程度有限或存在调研活动参与意愿较低的情况，研究团队通过整合社区服务资源，联合专业心理辅导人员，采用分层筛选机制确定调研对象。经过对目标群体的认知能力评估与心理疏导干预，最终选定符合调研条件的 78 名老年群体作为样本，完成问卷发放工作。最终收回有效问卷 73 份，回收率 93.6%，参与此次测试的独居老人均独立或在他人的协助下认真进行了作答。笔者通过对有效问卷的整理和数据分析，发现其中有 44 位老人都有不同程度的抑郁情绪问题，占调查总量的 60.2%，且大部分老人的这种抑郁倾向已经持续了一段时间。

表 3-2 Z 社区独居老人抑郁情绪分布统计

GDS 得分	测试结果	人数	占比
0-5	无抑郁情绪	20	27.3%
11-20	轻度抑郁	38	52.0%
21 及以上	中重度抑郁	15	20.5%
0-15	总计	73	100%

从表中可以看出，对社区独居老人的抑郁情绪进行干预十分必要。

二、Z 社区独居老人的抑郁情绪的现状分析

（一）情绪低落，焦虑不安

在针对存在抑郁症状的独居老年人展开沟通访谈时，观察到该群体普遍表现出言语互动贫乏、交流意愿低迷、肢体紧绷以及坐姿频繁调整等焦虑特征。其行为模式深刻映射出强烈的孤独情绪与持续心境低落状态。受访对象普遍显露对亲情支持与日常陪伴的深切期待，然囿于多重现实因素制约，此类核心需求往往难以实现。同时，她

也担心自己会成为别人的负担，因此选择了独自承受孤独，久而久之，就会产生或者加重其抑郁情绪。笔者在访谈过程中发现，有的独居老人会常常叹气，有的还会低声哭泣。能够明显感受到他们的情绪低落，陷入抑郁的情绪之中难以自拔。

社工：您好，张奶奶，感谢您愿意接受我们的访谈。听说您最近感觉心情不太好，能和我们分享一下吗？

张奶奶：唉，是啊，孩子。我这心里总是空落落的，有时候还会觉得心慌意乱。

社工：是觉得孤单吗？还是有什么别的事情让您不开心？

张奶奶：孤单是肯定的，孩子们都在外地工作，老伴也走了，家里就我一个人，家里冷冷清清的，连个说话的人都没有。而且，我这身体也不太好，出门也不方便。

（二）丧失乐趣，陷入不良生理状态

独居老年人的抑郁情绪常表现为对生活乐趣的持续性丧失。这种丧失并非短暂的情绪波动，而是长期独居状态下对曾经热衷活动的深度疏离。这种对生活热爱的消退，实质反映了个体内在生命力的萎缩。兴趣的丧失不仅削弱了老人的日常活动动机，更导致其陷入“无意义感”的认知困境，形成“活动减少→情绪低落→功能退化”的恶性循环。与此同时，抑郁情绪常引发显著的生理功能紊乱。抑郁状态会通过内分泌系统影响机体代谢，导致睡眠障碍、食欲减退、体重下降等躯体症状。研究显示，长期抑郁的独居老人患慢性疼痛的概率较非抑郁老人高出 34%，免疫力下降引发的呼吸道感染风险增加 27%。更隐蔽的危害在于，生理症状与心理问题相互作用，形成“躯体化”表现——老人可能将抑郁情绪转化为对自身健康的过度担忧，反复就医却查无器质性病变，进一步加重心理负担。这种身心交互作用的困境，使得抑郁情绪成为威胁独居老人生活质量的核心风险因素。

社工：王爷爷，今天天气不错，您平时喜欢在社区里逛逛吗？

王爷爷：能不出门就不出门……以前老伴还在的时候，还能说说话，现在连个拌嘴的人都没了。街坊邻居？他们都有自己的事，哪有工夫听老头子唠叨。

社工：那您晚上一个人会不会觉得孤单？

王爷爷：习惯了……就是有时候半夜醒了，听着外面的风声，突然觉得这房子大得吓人。”

社工：听说社区有老年食堂，您经常去吃饭吗？

王爷爷：不去，麻烦。自己随便煮点挂面得了。

社工：您有没有想过去找社区志愿者陪您聊聊天？

王爷爷：不用！他们只会问东问西，填完表格就走。

（三）封闭内向，人际交往能力弱

独居老年人的抑郁情绪常伴随显著的社会退缩行为，这种弱化并非单纯的性格孤僻，而是抑郁情绪与社交环境交互作用的复合结果。在物理空间层面，独居老人因行动能力受限或对社交风险的过度警惕，逐渐缩减外出频率，甚至长期闭门不出。在社交质量层面，抑郁情绪导致沟通能效的断崖式下跌。语言交流从主动分享转为被动应答，常用“还行”“随便”等模糊化表达规避深入互动。在访谈过程中，有位老人表现为别人问一句，她就答一句，多了怕说错话。这种高度程式化的对话模式，实则是自我保护机制的外显。这种表现会引发恶性循环的后果，社交退缩导致语言表达能力退化，出现“假性失语”或沟通回避，进一步削弱人际吸引力；情感需求的长期压抑易催生认知偏差，加剧对他人的不信任感。

社工：爷爷您好，我是社区服务中心的小林，今天来和您聊聊天，了解一下您最近的生活情况。咱们就随便说说，您别紧张。

王爷爷：没什么可说的……每天不都一个样么。早上天不亮就醒，躺着听楼下早点摊的动静，油锅里滋滋啦啦的，吵得人头疼。中午凑合弄口饭吃，下午在阳台上数对面楼顶的鸽子，数到第七只就飞走了，剩下的再数一遍，数到天黑。

社工：听您描述这些，感觉日子挺孤单的。您平时会想出去走走，或者找邻居说说话吗？

王爷爷：出去干什么？见着人总得打招呼吧？张家长李家短的，我嘴笨，接不上话头。上次在菜场碰见老同事，人家问我最近忙啥呢，我说活着呢，话一出口自己都嫌晦气。年轻时候我就不爱凑热闹，现在更没这个心了。

社工：您别这么说，每个人都有需要陪伴的时候。如果您愿意，我们可以每周安排志愿者

来陪您读书看报，或者一起去公园听戏？

王爷爷：不必了。戏文里唱的，热闹是他们的，我坐那儿像块石头。你们年轻人时间金贵，何必耗在我这个废人身上。

（四）自我否定，丧失自信心

许多独居老年人因步入高龄阶段，身体状况日渐衰弱，导致他们在应对日常琐事时感到颇为艰难，自我照料的能力逐渐减弱。这种能力的下滑往往使他们内心充满挫败情绪，认为自己相较于他人有所不及，缺乏自我价值感，自信心丧失，未能建立起积极的自我认同。这一系列心理变化，进而引发他们的焦虑情绪，并可能深化为抑郁状态。另外，部分独居老人在退休之后，虽积极参与各类老年活动，但由于在某项运动上不甚擅长，难以从中获取成就与满足感，这对他们的心理状态亦产生了不利影响。

王爷爷：唉，前几天走路不小心摔了一跤，现在腿疼的什么也干不了，你们来了，唉，看我把饭做成什么了，现在什么都干不好了，你们说我活着乏不乏味。

陈奶奶：以前我还能自己照顾自己，现在感觉越来越不行了，心里挺不是滋味的。

笔者在访谈中发现，部分独居老人会出现错误的自我认知，觉得自己不如他人，觉得自己没有用，从而躲避社会交往，把自己关在家里，久而久之自卑心理愈发严重，他们就变得更加内向，更不愿意和其他人说话了。

第三节 Z 社区独居老人的抑郁情绪的成因分析

一、生理因素

随着年龄的增长，老年人的身体机能逐渐衰退，内分泌系统和神经系统等生理机能发生变化，这可能导致他们的情绪调节能力下降，更容易产生抑郁情绪。例如，神经递质如羟色胺和去甲肾上腺素在老年人脑内的水平可能发生变化，这些神经递质在情绪调节中起着重要作用，它们的失衡可能导致老年人出现抑郁情绪。

其次，还有大部分可能面临多种慢性疾病，如心血管疾病、糖尿病、关节炎等，这些疾病带来的身体不适和疼痛不仅影响他们的生活质量，还可能引发心理压力，从而导致抑郁情绪的产生。此外，一些药物如心血管药物和中枢神经系统药物的长期使用，也可能对老年人的情绪产生负面影响，增加抑郁的风险。

张爷爷：我时因为有心脏方面的疾病，需要长期服用药物时，我以前睡眠挺好的，但自从开始吃药，就经常失眠，或者半夜醒来就再也睡不着了。然后，我的食欲也变差了，不想吃东西，体重还下降了一些有时候，这病一找上你啊，它就轻易不下去。

社工：听起来确实很让人难受。那您觉得这种情绪变化跟您吃的药有关系吗？

张爷爷：我觉得有关系。因为我看过药的说明书，上面有些副作用就是会引起情绪低落或者抑郁。而且，我也跟医生聊过，他说有些药物确实会对情绪产生影响。

刘奶奶：我自小体弱多病，从年轻时起就与各种慢性病相伴，一直吃药治疗，但似乎总是治标不治本。我尝试过各种药物，从中药到西药，从口服到注射，然而病情总是时好时坏，让人心力交瘁，那些药物，有的让我昏昏欲睡，有的则让我整夜难眠，身体状况非但没有好转，反而越来越差。

二、社会环境因素

（一）居住环境改变，生活单调

根据社会认知理论框架，个体认知过程、行为模式及所处环境之间呈现出相互依存与动态关联的互构关系。当老年群体经历生活场域的变迁时，其既有的认知体系与日常行为惯习必然受到显著冲击。以某社区老年居民为例，该群体多源于周边乡镇的集中迁入，这种空间转换不仅割裂了原有的地缘社交网络，更消解了长期建立的社会支持系统。新型居住空间的陌生感与建筑格局的密集化，显著降低了邻里互动的便利性，形成社会联结弱化的客观困境。部分老人反映，搬迁至此之后，与昔日的老友失去了联系，从前那种庭院相邻的生活状态不复存在，如今身处高楼，难以适应，加之与新邻居不熟悉，只能独守家中。还有老人感到自己从乡村迁来，自觉被他人轻视，

与周围老人缺乏共同话题，日常无处可去，只能依靠观看电视来消磨时光，这种孤独的生活状态，在一定程度上诱发了抑郁情绪的滋生。

王奶奶：我以前是和老伴一起住在老城区的一个小巷子里，那里虽然破旧，但邻里关系很好，大家经常串门聊天。后来老伴去世了，孩子们也都在外地工作，我就搬到了这个新社区。

社工：那搬到新社区后，您的生活环境和居住方式发生了哪些变化呢？

王奶奶：变化可大了。以前在小巷子里，出门就能碰到熟人，大家一起聊天、下棋、打牌，日子过得很充实。现在在这个新社区，虽然设施更好了，但邻居们都不熟悉，我很少出门，连对门的邻居都没怎么说过话。

（二）人际关系的疏离

独居老人产生抑郁情绪，很大程度上是因为身边的人际关系越来越淡薄。很多老人年轻时家里热热闹闹的，子女结婚生子后各自搬出去住，老伴去世后更是只剩下自己一个人。亲戚朋友住在不同的城市，一年见不上几次面，连串门的人都少了。住在同一个小区的邻居看似近，但实际上大家各忙各的，很少主动打招呼。有位张奶奶说得好，现在连对门住了十几年的人姓什么都不知道，有事找人都得挨家挨户敲门。这种孤独感还会从生活中渗透进去。比如家里坏了灯泡不敢找人修，生病了熬着不去看医生，怕给别人添麻烦。社区虽然有志愿者偶尔上门送米送菜，但大多只是匆匆放下东西就走，坐下来聊天的机会更少。最让人难过的是，老人心里其实特别渴望有人陪自己说说话。有的老人会反复翻看老照片，念叨着过去的事情；有的整天守着电视，其实根本没在看节目，只是听着声音有个伴儿。其次，现在年轻人的生活方式变化也加深了这种隔阂。孩子们忙着加班、照顾自己的小家庭，视频通话时手机屏幕上全是孩子的脸，老人想多说几句却被嫌弃“叨叨”。这种由人际关系疏离引发的抑郁情绪，就像一棵慢慢生长的毒草。它不会立刻致命，但却会一点点啃食老人的生活热情。

社工：张爷爷，您在这附近住了二十年，平时和邻居们相处得还顺利吗？

张爷爷：以前每天早上都能听到楼道里此起彼伏的问候声，现在连电梯里的广告都比人声热闹。上周三我特意把垃圾袋系紧挂到门口，结果直到周五才被人收走——不是没人看

见，是大家都装作没看见。

社工：那您的子女平时会来看望您吗？

张爷爷：大女儿在深圳开公司，视频通话时背景总是亮着正在会议中，小儿子在杭州本地，上周说好要带孙子来吃饭，结果孩子发烧临时改约。您看这个全家福，还是二十年前的清明节拍的，现在连墓碑照片都比这更新鲜。上个月我胃出血住院，护士问家属电话，我报了儿子号码，结果接电话的是他老婆，说老爷子您别激动，我们正忙离婚呢。

（三）社交圈子的缩小

独居老人缺乏社会交往能力的具体表现多种多样，首先体现在他们往往较少参与社区活动，即便有意愿，也可能因身体条件限制或信息不畅而难以成行。他们与邻居的交流也往往局限于礼貌性的点头之交，难以建立起深厚的友谊。在通讯工具的使用上，许多独居老人对智能手机、社交媒体等现代通讯方式感到陌生，无法通过这些平台与朋友、家人保持联系，进一步加剧了他们的孤独感。此外，由于缺乏有效的社交技巧，他们在面对新环境或新人群时可能会感到不自在，难以主动融入新的社交圈子。

社工：那您平时会参加一些社区活动或者和邻居们交流吗？

李爷爷：不太多。我这腿脚不方便，出门一趟挺费劲的。邻居们我也都不熟悉，不知道怎么开口聊天。

社工：那您有没有尝试过通过一些方式，比如电话或者网络，和朋友们保持联系呢？

李爷爷：我不太会用那些新玩意儿。手机也就打个电话，上网什么的都不会。

三、经济因素

对独居老年群体而言，构建稳固的经济保障体系是维持晚年生活质量的核心要素。经济储备的充足性直接关联到老年生活的自主性、安全性及幸福感，尤其当法定养老收入成为主要经济来源时，其稳定性与可持续性成为关键考量。部分独居老人在年轻时，因家庭经济条件有限，未能接受良好的教育，早早便踏入社会，开始在工厂从事高强度的工作，这一干就是数十年。尽管他们付出了辛勤的汗水，但收入却十分微薄，

甚至因此落下了职业病。当他们步入晚年，或因年龄过大而无法继续工作时，才发现退休金寥寥无几，积蓄也所剩无几。

随着生命周期的推进，老年群体普遍面临多病共存现象，需长期依赖药物治疗维持健康状态。然而现行医疗保险制度存在保障边界，部分必需药物需患者自行承担费用，这对经济储备有限的老年群体构成显著经济压力。值得关注的是，代际经济支持现象进一步加剧了老年群体的经济脆弱性：部分独居老人为满足子女购房等家庭重大支出需求，通过借贷方式筹集资金，日常消费则极度压缩，形成债务偿还导向的生存策略。

张爷爷：我退休以后，生活更陷入了困境。家中条件本就拮据，在外工作的孩子虽已成年，但生活压力也不小，时常需要我补贴一下，孩子都要结婚，还在攒需要的费用，年轻的时候，还能打打工多赚点钱，现在退休后，微薄的退休金成了我唯一的收入来源。

第四节 Z 社区独居老人缓解抑郁情绪的需求分析

基于抑郁症状的表征与诱因研究可发现，长期独居的老年群体在独居状态持续过程中，其日常行为模式将发生系统性改变，这种生存方式的重构深刻作用于心理机能状态。随着时间维度的延伸，环境剥夺效应与社交缺失形成的复合性压力源，将导致负性情绪体验呈现累积性增强趋势。研究表明，该群体需要构建多维支持网络以修复心理弹性，通过专业干预与社会支持系统的协同作用，方能实现心理状态的重构与生活质量的提升，最终恢复对生命价值的积极认知。

一、情感慰藉需求

社区独居老人的抑郁情绪需求根植于多重社会心理困境的交互作用。通过入户访谈与量表筛查发现，独居老人普遍存在“隐性抑郁”特征，他们往往将情绪问题归因为年纪大了都这样，却长期承受着社交孤立与生活意义缺失的双重压力。68 岁的王阿姨在访谈中坦言：孩子在外地工作，每天除了买菜就是看电视，有时候对着窗户发呆

一整天，连个说话的人都没有。这种空虚感在 15 名受访者中高频出现。这些需求与园艺疗法特性高度契合——自然接触缓解焦虑、植物生长隐喻希望、协作任务重建联结，共同构成针对独居老人抑郁情绪的系统应对方案。

二、社会支持方面的需求

在信息时代背景下，部分长期处于封闭生活状态的老年群体因社会联结断裂而面临显著的信息壁垒。以某位丧子独居老人为例，其子女分别因意外事故与海外定居无法提供生活支持，面对社区公共事业缴费方式向数字化平台的转型，该群体因缺乏信息获取渠道未能及时完成费用缴纳，最终导致长达二十四小时的电力中断。这一典型案例深刻揭示出独居老年群体在家庭支持系统崩溃与社会适应能力衰退双重压力下的生存困境。这个案例折射出独居老人面临的双重困境——家庭支持缺失与社会适应性不足。基于前述分析可见，保障独居老年群体及时获取公共政策调整信息及生活环境动态，对其维持社会联结具有关键意义。该群体支持体系的构建需以公权力机构为主导，通过制度性安排确保信息触达的时效性，同时需要动员社会力量参与服务供给网络的建设。这种多方协同的支持模式不仅有助于满足老年群体的生存发展需求，更能通过环境适应能力的强化，促进其形成持续的社会参与效能。值得关注的是，政策支持与社会服务需要形成动态响应机制，方能有效应对老年群体在环境变迁中的多维挑战。

三、人际交往方面的需求

访谈发现，72%的老人因长期独居形成“习惯性沉默”，既渴望情感联结又畏惧主动接触，陷入想说话却找不到人，有人来又不敢开口的矛盾状态。68 岁的张爷爷坦言：“社区活动室天天开着，但去了三次都没人搭理，后来就窝在家里看电视了。”这种挫败感在人际敏感群体中尤为突出。步入人生晚年阶段，个体脱离职业场域后，原有的社会互动模式发生显著改变。当劳动者结束职业生涯，其日常交往频率往往呈现下降趋势，人际沟通的必要性亦随之弱化。在此情境下，若配偶长期缺席且子女因工作

或生活原因无法常伴左右，老年群体容易陷入情感支持的真空状态。此时，构建稳定的同辈交往网络显得尤为重要——通过主动参与群体性社交活动，个体能够将日常困扰诉诸具有相似生活经历的伙伴，借助集体智慧寻求问题解决方案。相较于封闭式的自我消化模式，这种开放型的交流机制更有利于心理压力的纾解。

四、改变偏差认知需求

部分老人存在“年龄即终点”的固化思维模式，这种认知偏差显著阻碍了其参与社会活动的意愿。王爷爷在访谈中直言，人老了就只能待在家里，搞社交那是年轻人的事，我们这把老骨头只会添麻烦。这种将老年生活等同于被动接受照顾的观念，往往源于社会对老年角色的刻板定位及个体长期缺乏价值体验。消极认知会通过自我实现预言加剧情绪困境——当老人认定自己不配参与社会活动时，便会主动回避人际互动，进而强化孤独感与无助感。从而需要消解“无用论”的消极信念，最终实现从“被动生存”到“主动生活”的认知转型。

五、自我价值实现需求

社区独居老人的自我价值实现需求源于退休后社会角色剥离与能力认同缺失。许多老人长期陷入“无用感”漩涡，将生活简化为吃饭、睡觉的机械循环，这种价值危机在访谈中具象化为68岁李奶奶的感慨，退休前天天给学生批作业，现在连盆花都养不活，活着就像个摆设。这种自我否定往往伴随身体机能衰退而加剧。还有独居12年的刘爷爷说不是不想帮忙，可谁会找七旬老头做事？这些实践表明，独居老人迫切需要通过可感知、可持续的成就载体重建自我价值。

第五节 小组工作介入社区独居老人的抑郁情绪的必要性 和可行性分析

一、必要性

首先深入探访调查 Z 社区独居老人才能真切感受到抑郁情绪像片乌云罩在不少老人心上，由于亲人不是因工作忙就是住得远不能常陪身边致使老人长期陷于情感孤寂之中，情感缺乏让老人生活热情慢慢丧失且对未来的期盼也越来越淡，长年独居且跟外界有效交流越来越少使老人社交圈子渐渐变小从而孤独感进一步加深甚至可能出现抑郁或者加重抑郁状况对其心理健康威胁严重，所以寻个有效办法改善独居老人抑郁情绪是我们急需解决的事。

第二，园艺小组这种独特的社交形式魅力在于能把热爱自然、渴望交际的个体紧紧联系起来，并且成员共同参与园艺活动时能基于共性需求确定明确的小组目标，在 Z 社区不少独居老人被抑郁情绪困扰而园艺小组一介入就给他们带来温暖，它从细节着手探寻老人抑郁的根源并组织开展像种花植树、修剪枝叶、交流园艺经验之类的各式各样园艺活动，这既能极大丰富老人精神生活又能推动他们交流互动从而使他们慢慢建立起新的社会支持网络。

独居老人参与园艺小组，这不但是一个释放压力、愉悦心情的平台，更是让他们重新找回生活热情、走出抑郁的关键途径，并且园艺小组活动时，老人能感受到同伴的关心和支持，享受到与自然和谐相处的乐趣，这对他们重拾对生活的信心和期待有帮助，所以园艺小组介入社区独居老人抑郁情绪问题，不但有必要，而且有着重要的现实意义。

二、可行性

笔者回顾过往社区活动记录时首先就发现，该社区之前成功举办了“绿意盎然，乐享晚年”园艺兴趣小组以及“花香伴我行，心灵手巧乐”花卉养护小组等活动，老

年居民特别喜爱，可见园艺小组活动形式很受老年人欢迎且认可度很高，所以园艺小组介入社区独居老人抑郁情绪问题有着不错的群众基础。

第二，在策划园艺小组活动方案时，凭借扎实专业知识，笔者精心设计活动流程并明确小组目标、理论依据、潜在挑战及应对策略，还把预算计划详细列出，之后和团队成员多次讨论修订，项目主管和专家也严格审核，最终将活动方案确定下来，保证园艺小组活动有专业性且可操作化。

第三，在市政府推进社区心理健康服务项目的背景下，本次园艺小组活动得以开展且得到相关部门的政策扶持与资金资助，活动进行时社区提供宽裕场地和必要设施，专业社工机构负责提供园艺工具并供给专业指导人员，有如此给力的资源保障，园艺小组活动就能顺利开展，因此，园艺小组介入社区独居老人抑郁情绪问题是合老年人实际需求的，并且在政策、资源、专业等方面都是可行的。

第四章 小组工作介入社区独居老人抑郁情绪的实务研究

园艺疗法的理念被本章运用并贯穿于整个小组活动，园艺小组实践活动详细记录每次活动的具体内容，并采用小组工作形式，由于小组工作重视团队凝聚力所以在构建独居老人互助体系方面起着关键作用，小组活动中老人们分享个人体验感受以促进组员间相互支持协作，一起应对独居老人生活和心理上的问题从而更有效地缓解抑郁情绪、建立自尊心并重新发现生活意义，小组工作灵活性高可根据组员实际情况动态调整，在老年服务领域比其他工作方法有独特优势，园艺疗法丰富了小组活动内容还给独居老人提供借助自然疗法改善心理状态的途径。

第一节 小组准备阶段

一、小组准备

组建研究小组之前，笔者就深入考量了独居老人独特的需求与潜在的挑战，像健康方面的问题也许会阻碍他们参加活动、对集体活动或许会有不适应的心理、过往的心理创伤也许会引起突发情况等，并且按照社会工作的专业规范，笔者精心挑选人员。

社工在开展老年群体小组互动服务之前得跟养老机构相关人员建立起协同工作机制并借助深度访谈和需求评估确定服务方向。按照专业服务伦理要求，工作人员和长者交流时要注意措辞合适且要体现出人文关怀的温柔回避可能导致心里不舒服的表述方式，在颐和社工的实践经验里这语言表达策略已经很成熟了。工作团队想要让服务活动有专业性、系统性就得事先把服务方案系统地规划好并且借模拟演练预先检验活动流程是否合理，社工案例的服务步骤策略里这一准备工作流程被充分证实。

服务实施阶段采用多维度协作模式，督导统筹全局，其他社工负责流程衔接，观

察员用标准化评估工具记录参与者行为特征与情绪变化，阶段性服务结束后，通过焦点小组访谈、满意度测评等方式收集反馈信息，系统梳理活动成效和不足并据此优化后续服务方案，需要注意的是，服务全周期都贯穿人本服务理念，不但要重视活动形式创新，更要强调建立情感联结，利用非语言沟通技巧和正向激励策略提升长者参与意愿，老年社工实践案例表明这一服务理念有显著优势，整个服务流程形成计划-执行-评估-改进的良性循环，既能遵循社会工作专业规范，又能充分回应老年群体个性化需求。

二、小组活动设计

（一）介入方法

在社会工作领域，小组工作方法是个重要的干预范式，其核心是靠专业引导激发群体动力来促使成员间形成互助性支持系统，社工用关系建立、资源整合等专业技巧在团体场域催化成员互动以推动个体行为修正和社会适应能力发展，从而最终达成组织目标与社区发展需求一起实现。在我国治理体系里，政府职能部门、企业机构、社会组织都大力倡导发展兴趣导向型、志愿参与型团体活动，借成员间的正向互动和支持系统构建促进个体社会化的机制。

独居老年群体服务对这种干预模式有很强的适配性，通过把具有相同需求或者困境的独居老人纳入结构化支持网络来设计主题化团体活动，再利用集体效能优势构建问题解决机制，这样既能增强个体心理韧性，还能促使代际关系得到修复并且让老人融入社区，以团体为介入载体的这种策略可有效弥补传统个体服务模式在资源链接和社会支持方面的局限，给老年群体构建一个更具持续性的社会参与平台。

（二）介入目标

明确社会工作实务具体方向的前提是明确小组工作的目标。

总体目标：用专业的小组工作理念、方法与技巧开展园艺小组活动以有效干预独

居老人的抑郁情绪，助力他们摆脱孤独、失落之类的负面情绪困扰并重拾积极健康的心理状态。

从小组活动的具体目标来看，可从认知水平、活动能力、社会交往和自我效能感这四个维度对其进行细化。

首先，身体维度融入运动元素的活动能激活大脑功能、提升思考、反应与创新能力并且还能鼓励长者挖掘个人潜能来有效对抗身体机能的渐趋下降。

其次，活动里老人们自己种植物并加以照料，体验到生命的变化成长，从而获得久违的成就感与满足感，并且园艺小组集体互动让老人感受到温暖陪伴，有效缓解抑郁情绪。

最后，在社交方面努力打造一个助力长者沟通协作的平台以营造组内相互扶持的良好氛围，该平台推动人际积极互动并扩大社交圈，而且相互间的鼓励赞赏让长者的成就感、愉悦感和自我认同感更强，从而构建出一个强大的社会支持网络。

（三）研究对象

在确定调研对象时，研究会充分考虑老年群体特殊的需要以及个体间的差异性，由于老年人生理机能有限且常行动不便，所以要结合他们的心理健康状况和生活场景特点系统地筛选人员，首先把那些认知功能有障碍或者躯体活动能力极度衰退的人排除掉，然后对于有社交回避倾向或者处在创伤恢复期的特殊人群，重点评估他们参与社会活动的适应情况，最后用老年抑郁量表（GDS）选出符合条件的长者作研究对象，20 名受试者被纳入其中，并根据人口学特征（像年龄、性别）、功能指标（例如认知水平、躯体活动能力）还有主观意愿（比如参加园艺活动的兴趣）随机分成两组，实验组和对照组各有 10 人。

进行随机分组，形成实验组与对照组分别 10 名。

研究对象需满足以下条件：

1. 年龄范围：参与者需年满 60 周岁及以上。
2. 抑郁情绪筛查：通过老年抑郁量表（GDS）测试，受试者需存在轻度或中度抑

郁症状（GDS 评分：11-25 分之间）。

3. 功能状态要求：参与者需具备基本的肢体活动能力（如独立行走或完成简单动作）及语言沟通能力（可清晰表达需求并理解其意思）。

研究对象需排除标准：

1. 存在认知功能障碍或躯体活动能力严重衰退的个体
2. 处于严重创伤恢复期的特殊群体。

（四）小组特征

1. 小组名称：“园艺陪伴·绿意心愈”小组
2. 小组性质：互助、支持小组
3. 小组节数：7 节（2024 年 3 月 27 日--2024 年 6 月 8 日，每 1-2 周一次）
4. 活动地点：Z 社区党群活动中心会议室
5. 活动对象：Z 社区 60 岁以上, 满足纳排标准，GDS 得分在 11-25 分的独居老人。

三、小组工作计划

园艺疗法的干预模式组织老年群体参与园艺观赏与种植实践，凭借植物在品种、色泽、形态、气味等方面的多样特性以及园艺材料的创造性运用和种植成果的互动性体验给独居长者构建多维度感官激活系统，这类活动带来视觉审美体验、芳香感知刺激、触觉交互训练，促使参与者在生理健康、认知功能、社会交往能力、艺术创造力等方面全面提升，在实践中长者完成园艺作品创作和植物养护任务后逐渐建立起主体价值认同和情感效能感，从而缓解负面情绪困扰，达成心理调适和社会融入的协同发展，最终形成包含身心健康发展、社会支持增强、精神生活品质提高的复合型园艺干预效果。

首先在认知水平层面，独居老人的认知功能受园艺活动的积极影响，因为种植时需记住植物养护方法与生长周期，这可锻炼老人记忆力和注意力，并且观察记录植物生长变化能提升老人观察力与逻辑思维能力，持续的认知刺激有助于延缓认知衰退并

让头脑保持清晰。

园艺活动在活动能力方面能增强独居老人身体活动能力，因为从简单播种浇水到复杂修剪移植都得老人用全身力量并讲究协调性，而且随着园艺技能提高老人动作会更灵活敏捷，另外园艺活动还能激发老人创造力和想象力使其在生活中找到更多乐趣与动力。

社会交往方面，独居老人有了园艺小组这样一个社交平台，在一起种养植物时能互相交流心得、分享经验从而建立起深厚友谊，这样的社交互动可减轻他们的孤独与抑郁并提升生活满意度和幸福感，此外园艺小组还能给老人情感支持和心理安慰使其感受到社会的温暖与关爱。

自我效能感方面，老人们亲手种养植物并修剪，看着种子发芽直至开花结果能直观地收获成就感，且在组内分享养护经验可强化自我价值认同，社区公共空间展示成果也让老人们觉得被社会需要很有意义，因此抑郁情绪就在泥土芳香和生命力量中逐渐得到改善。

园艺活动方案具体内容如表所示：

表 4-1 园艺活动对抑郁情绪长者不同层面的干预		
介入层面	活动节次	活动内容
认知水平	第 1 次-第 5 次	认识园艺疗法, 了解植物知识, 学习小型花园的设计方法, 学习绿植与花卉的修剪技巧, 了解社区花园的植物, 学习种植知识和报纸育苗盆制作方法
活动能力	第 1 次-第 7 次	参观体验, 卡片式摆放花园, 植物修剪, 制作报纸育苗盆, 分享养护经验, 展览布置
社会交往	第 1 次-第 7 次	学习分享感受, 智慧贡献, 分享养护经验, 展览布置, 故事分享
自我效能感	第 3 次-第 7 次	绿植养护、社区共建、成果展示, 通过植物培育、方案设计、作品创作等实践

每次的园艺活动的内容基本分为三大部分：破冰游戏（5-10 分钟，帮助组员快速融入小组，增添和谐愉快的气氛）、主题活动（25-40 分钟，通过园艺活动疗愈身心，促进彼此沟通交流，提高自我认同）、总结分享（10 分钟，分享个人感受，促进正向思考）。

（一）园艺疗法团体辅导小组组员前测

1.小组组员的基本情况

表 4-2 研究对象基本信息表

变项	类别	实验组		对照组	
		总人数	百分比	总人数	百分比
性别	男	4	40.0%	4	40.0%
	女	6	60.0%	6	60.0%
年龄	60-69 岁	2	20.0%	3	30.0%
	70-79 岁	4	40.0%	3	30.0%
	80-89 岁	4	40.0%	4	40.0%
文化程度	小学及以下	2	20.0%	2	20.0%
	初中	4	40.0%	3	30.0%
	高中	3	30.0%	3	30.0%
	大专及以上	1	10.0%	2	20.0%
抑郁程度	轻度	8	80.0%	9	90.0%
	中度	2	20.0%	1	10.0%

2.小组组员介入前的抑郁情况

园艺小组开展前，随机将 20 名独居老人分为试验组和对照组，并用老年抑郁量表（GDS）分别对试验组和对照组的 20 名独居老人的抑郁情况进行前测，从而得到独居老人在园艺小组开展之前的抑郁情绪的数据资料。实验组前测抑郁水平均值为 18.40 分（标准差 1.84），根据老年抑郁量表（GDS）的评分标准（11-20 分为轻度抑郁，21-30 分为中度抑郁），该组老人普遍处于中度抑郁临界状态。干预后 T 检验结果显示，T 值达到 6.873（ $p=0.000$ ），远高于统计学显著性阈值（ $p<0.01$ ）。对照组前测均值为 17.40 分（标准差 3.37），其初始抑郁水平略低于实验组，但组内个体差异更为明显（标准差高出 83%）。值得注意的是，该组 T 值为-0.122（ $p=0.000$ ），未呈现统计学显著性。

表 4-3 实验组配对样本 T 检验（N=10）

前后测	均值	N	标准差	T	Sig（双侧）
前测	18.40	10	1.84	6.873	0.000***

注：* $P<0.05$ ；** $P<0.01$ ；*** $P<0.001$

表 4-4 对照组配对样本 T 检验 (N=10)

前后测	均值	N	标准差	T	Sig (双侧)
前测	17.40	10	3.37	-0.122	0.000**

注：*P<0.05；**P<0.01；***P<0.001

第二节 园艺小组活动的展开

一、第一次小组活动：破冰·园艺初体验

1. 主题：破冰·园艺初体验
2. 阶段目的：通过趣味游戏与植物认知，打破社交沉默，建立初步信任关系，激发老人对园艺的兴趣。
3. 时间：2024 年 4 月 3 日
4. 地点：社区党群服务中心活动室
5. 活动计划安排

表 4-7 小组第一次活动：破冰·园艺初体验

小组第一次活动：破冰·园艺初体验				
活动时间：2024 年 4 月 3 日 13：00-13：50				
活动地点：社区党群服务中心活动室				
序号	活动环节	活动具体内容	时间	物资
1	活动简介	社工进行简短的自我情况的介绍，并清晰地向组员介绍整节活动的目的和各节小组活动的内容。最后详细的介绍本节活动的流程和具体内容	5 分钟	
2	破冰阶段	社工带领组员开展破冰游戏。在这一阶段，阶段的核心任务在于营造安全信任的群体氛围，激发成员参与动能。本次活动开展了”趣味手指操”活动，选取手部协调性训练项目作为媒介	10 分钟	音响、纸、笔

3	组员分享	社工首先实施情绪舒缓引导程序，帮助成员建立心理安全感。继而设置基础信息交互环节，通过渐进式引导鼓励成员进行结构化自我表露。	10 分钟	
4	认识园艺疗法	具体实践通过“植物配对识别”互动游戏，引导成员在趣味体验中建立基础植物学知识体系，为后续治疗性活动开展奠定认知基础。	20 分钟	彩色笔、卡片若干
5	记录	发放事先准备好的 A4 纸，引导并协助组员记录自己此时此刻的情绪和感受	3 分钟	纸、笔
6	总结	社工对本次小组活动进行总结，并对下次小组活动发出预告和邀请	3 分钟	

社会通过结构化破冰环节与园艺体验活动的系统设计，旨在促进成员间建立初步情感联结，同时培育参与者对园艺疗法的认知基础。在小组契约形成过程中，社工着重强化规范共识的民主建构，通过观察可见，该模式有效促进了独居老人心理维度的综合改善。

活动开始，负责人站立于环形布局的活动空间中心位置，以开放式肢体语言与温和面部表情营造接纳性氛围。开场陈述采用标准化欢迎方式，社工首先进行专业角色说明，继而表达与老年群体共同参与的期待感。在目标阐释阶段，社工强调园艺活动的双轨价值——既作为情绪调节媒介，又作为生活美学实践载体，通过预告活动框架帮助参与者形成心理预期。流程引导部分采用渐进式披露策略，既保持整体结构透明度，又为后续活动保留探索空间，体现了团体工作的节奏把控原则。……

接下来播放了一段轻快的音乐，社工引导大家做起“趣味手指操”。活动以“趣味手指操”开场，老人们跟随音乐节奏活动手指，这种简单易行的肢体互动不仅打破

了初次见面的拘谨氛围，还通过触觉和运动的刺激激活了大脑皮层，尤其对认知功能退化的老人起到了即时唤醒作用——组员李奶奶原本低头不语，在社工手把手带领下逐渐跟上节奏，活动后主动表示手指动一动，心里也跟着活络了。

社工：大家做得真好！没想到手指操这么有趣吧？看看，笑容都出来了呢！

李奶奶：是啊，我还从来没玩过这么好玩的游戏呢！感觉手指都灵活多了。

随着手指操的结束，社工引导大家放松下来，开始进行自我介绍和分享，由于组员不经常参加集体活动，对这一环节比较抗拒，没有人愿意主动站出来介绍自己。为此，社工首先进行自我介绍，打破僵局开始简单介绍，接着在社工引导下，为了加深组员相互间的了解和对园艺疗法得初次认识，随后进行的“植物连连看”游戏巧妙地将认知训练融入园艺主题，老人们在辨认薄荷、茉莉等植物卡片时，需要调用记忆力和注意力，这种主动思考的过程有效延缓了认知衰退，组员张爷爷原本总说自己“记不住事儿”，却在活动中准确说出三种花卉名称，社工观察到他眼神中难得的专注神情。通过本次小组活动，老人们不仅在轻松愉快的氛围中打破了陌生感，建立了初步的信任关系，还对园艺疗法有了初步的认识和兴趣。特别是通过“植物连连看”游戏和记录环节，老人们感受到了园艺带来的乐趣和放松，情绪得到了有效的缓解。

社工在活动结束后，与几位老人进行了深入的交谈，了解他们的感受和变化。

社工：您觉得今天的活动怎么样？有什么收获吗？

李奶奶：我觉得很好！通过游戏，我学到了很多关于植物的知识，也对园艺疗法有了更深的了解。我现在对养好植物更有信心了。

张爷爷：我也很高兴。来这里之后，我感觉自己不再那么孤单了。和大家在一起聊天、玩游戏，让我感觉很温暖。

最后是活动反思，在首次实施团体干预项目过程中，研究者观察到自身在引导成员参与治疗性游戏及导入园艺治疗理论时，专业引导技能的呈现存在明显生涩感，需在后续实践中重点优化流程设计。同时，目标群体作为园艺治疗模式的初体验者，对该干预模式缺乏认知基础，参与意愿薄弱。具体而言，当研究者阐释植物养护行为对孤独感缓解的作用机制时，部分成员出现注意力分散现象，表现为视线游离或低语交

流等非投入性行为，反映出当前活动设计在吸引力构建方面存在改进空间。建议后续研究阶段，需加强治疗前置性教育，通过需求评估动态调整活动设计，重点强化干预手段与目标群体兴趣谱系的契合度，以提升治疗依从性。

二、第二次小组活动：自然之旅·百花园探秘

- 1. 主题：感受自然·唤醒感官
- 2. 阶段目的：通过五感体验打破心理防御，建立自然联结，唤醒积极情绪，提升愉悦感，创造多样化的园艺体验，激发探索欲望。
- 3. 时间：2024 年 4 月 12 日
- 4. 地点：社区附近百花园
- 5. 活动计划安排

表 4-8 第二次小组活动：自然之旅·百花园探秘

第二次小组活动：自然之旅·百花园探秘				
活动时间：2024 年 4 月 12 日 13：00-14：00				
活动地点：社区党群服务中心活动室				
序号	活动环节	活动具体内容	时间	物资
1	回顾	简单回顾上次活动内容并介绍此次活动的主题和目的	5 分钟	
2	观看影片	观看园艺影片：用自然治愈心灵	20 分钟	

3	简要介绍目的地	社区工作人员和社工共同带领小组成员步行至百花园，并简要对百花园里拥有的植物与花卉进行介绍	10 分钟	小型麦克风
4	参观体验	在社区工作人员和社工带领小组成员参观百花园，近距离观赏、触摸以及辨识各类植物和花卉的触感和香气	15 分钟	折叠椅、遮阳伞、相机 橡胶手套
5	了解植物知识	参观植物展览，了解植物的生长习性、养护技巧及背后的文化故事	15 分钟	小型麦克风
6	分享感受	回到社区，组织老人围聚分享参观感受，鼓励表达个人情感	10 分钟	便签纸、笔
7	总结	社工对本次小组活动进行总结，并对下次小组活动发出预告和邀请	3 分钟	

在第一次小组活动中，组员们初步了解了园艺的基本知识，为了进一步加深他们对自然和园艺的热爱，我们设计了第二次小组活动——“自然之旅·百花园探秘”。

首先是将集合独居老人，社工简短介绍此次活动将带领大家到附近的百花园赏花，强调亲近自然的重要性，营造轻松愉快氛围，接着在社区工作人员和社工共同带领小组成员步行至百花园，一些小组成员表现出积极的心情和态度，但也有一些组员很自闭，不愿意去到室外参加活动，社工给予鼓励。接着社区工作人员带领小组成员们移步参观，简要对百花园里拥有的植物与花卉进行介绍，主要详细介绍了各种植物的生长习性和养护技巧，组员们边走边看，不时发出赞叹声。

张爷爷：哇，这些花真美，我感觉自己好像年轻了好多。

王爷爷：嗯，是啊，看着这些花，我都想起年轻时和老婆一起种花的时光了。

参观结束以后，社工将大家聚集在百花园的凉亭中，围坐一起，组员们纷纷分享了自己的参观感受。

唐爷爷：哎呀，这儿环境真好，真是太美了！还久还没见过这么多花呢，感觉心情都变好了。这次活动让我明白了自然的力量是无穷的。我觉得在大自然中，我好像内心平静了一些。

刘奶奶：嗯，我觉得这些花啊树啊的，都挺有生命力的，长的多好啊，看看它们，再想想自己，觉得生活还是挺有希望的。

张爷爷：我啊，就喜欢这种安安静静的环境，看看花，闻闻香，心里头那个舒坦啊，是钱买不来的。

陈奶奶：对，我也是。平时一个人在家，总觉得闷得慌。今天出来走走，看看这些植物，感觉整个人都精神多了。

李爷爷：我觉得这些花都挺有灵性的，看着它们，我就觉得自己也年轻了不少。

最后是活动的总结与反思，本次活动通过“多感官自然体验”打破了老人因长期独居形成的认知封闭状态，这种从被动接受到主动探索的转变，有效缓解了因认知衰退导致的思维迟缓问题，尤其对轻度认知障碍的老人起到早期干预作用。他们通过低强度的肢体参与感受到了大自然的美好，逐步恢复老人的身体机能与行动信心，还增进了彼此之间的友谊和了解。许多组员表示，这次活动让他们对生活有了些许期待，但是在活动开展过程中，我们也遇到了一些困难。例如，有些组员因为身体原因无法长时间行走；有些组员对植物知识了解不多，难以深入参与讨论。针对这些问题，我们采取了以下措施加以克服，对于身体不便的组员，我们提前准备了折叠椅和遮阳伞，让他们在休息时能够舒适地坐着；对于植物知识匮乏的组员，我们在活动前进行了简单的预习和讲解，并在活动中鼓励他们多提问、多交流。

三、第三次小组活动：巧手绘园·方寸之间见自然

1. 主题：小型花园创意设计工作坊

2. 阶段目的：引入社区花园设计概念并学习绿植与花卉的修剪技巧，聚焦设计思维，强化动手实践，形成可视化成果赋能。

- 3. 时间：2024 年 4 月 20 日
- 4. 地点：社区党群服务中心活动室
- 5. 活动计划安排

表 4-9 第三次小组活动：巧手绘园·方寸之间见自然

第三次小组活动：巧手绘园·方寸之间见自然				
活动时间：2024 年 4 月 20 日 13：00-14：00				
活动地点：社区党群服务中心活动室				
序号	活动环节	活动具体内容	时间	物资
1	回顾	简单回顾上次活动内容并介绍此次活动的主题和目的	5 分钟	
2	学习小型花园的设计方法	邀请园艺专家现场讲述小型花园的设计思路和方法，具体包括空间布局与规划、植物选择与搭配、细节处理与装饰、维护与管理	10 分钟	电脑和投影
3	卡片式摆放花园	提前准备好布置一个小花园所需的花卉卡片，成员们根据自己偏好摆放设计自己心中的小花园	20 分钟	卡片、纸、笔
4	分享想法	组织成员相互分享自己的摆放思路，分享自己对于小花园的功能、景观风格、植物种类等方面的期望和偏好	10 分钟	

5	学习绿植与花卉的修剪技巧	园艺专家现场讲述绿植与花卉的修剪方法，并播放 PPT 和视频让小组成员学习，强调修剪的重要性与技巧	10 分钟	电脑和投影
6	总结	进行简单的总结，并提前通知组员下一次的活动	3 分钟	

在园艺小组介入抑郁情绪独居老人的研究活动中，我们已成功开展了两次小组活动，发现园艺活动对于缓解老人们的抑郁情绪有显著效果。随着春天的到来，万物复苏，社工决定在第 3 次活动中，围绕“绿意盎然·修剪与设计”这一主题，进一步激发老人们对园艺的兴趣，从而更加积极地面对生活。

首先社工对于上一次参观百花园的活动进行回顾，讲述本次活动的目的，一起学习和实践小型花园的设计方法与绿植修剪技巧，鼓励大家能积极参与。接着社区特意邀请到了社区中负责园艺的工作人员，也是一名园艺方面的专家，给组员们讲述了小型花园的设计方法，具体包括空间布局与规划、植物选择与搭配、细节处理与装饰、维护与管理等方面。很多组员听不太懂，社工组织大家进行实践，在实践中继续体验园艺的乐趣，社工为大家准备好了布置一个小花园所需的花卉卡片，卡片中包括不同的植物种类，花卉种类，邀请大家根据自己的偏好，在一张 A4 纸上摆放这些卡片，设计出自己心中的小花园。社区的园艺专家在这个过程中，一步一步的带领组员，并时刻关注有没有组员跟不上的，对于不会摆放的或者没有思路的组员给予帮助。摆放结束以后，社工请大家相互分享自己的摆放思路，以及对小花园的功能、景观风格、植物种类等方面的期望和偏好。大家讨论的非常热烈。

王爷爷：我以前从没想过自己能设计出这么漂亮的小花园，真是太有趣了！

胡爷爷：这些花卉卡片真逼真，我都感觉自己像在真正的花园里一样。

陆爷爷：我看旁边的老李摆得真好，回头我也得向他学习学习。

唐爷爷：我设计的小花园主要是想用来放松心情的，所以选了很多颜色鲜艳的花卉。

刘奶奶：我想弄一个具有层次感的小花园，前面是低矮的花卉，后面是高大的树木。

王爷爷：我选的都是我喜欢的花卉，比如玫瑰、牡丹这些，看着就开心。

接着由社区园艺专家继续给小组成员讲述绿植与花卉的修剪方法，想让成员们多了解园艺知识，以便下次活动能够运用学的知识在生活中实践。

最后就是总结与反思，通过理论讲授与创意实践相结合的方式，系统性改善了独居老人的多维度心理状态。活动从认知层面切入，邀请园艺专家系统讲解小型花园的空间布局、植物搭配及修剪原理，帮助老人构建全新的知识框架。例如，组员在课堂上提出“高低错落种植可增强立体感”的构想，这种空间逻辑的主动运用正是认知功能改善的体现。在“卡片式花园设计”环节，老人通过排列组合花卉卡片完成虚拟空间规划，这种低门槛的创造性活动不仅激活了右脑形象思维，还通过组员间设计理念的碰撞激发了社交互动。同时，组员对着自己精心设计摆放的小花园凝视并自语“这是我亲手规划的花园”，这种对生活掌控感的重建也是抑郁情绪消解的关键转折。

在活动开展过程中，我们也遇到了一些困难。比如，有些老人对园艺知识了解较少，一开始很难跟上节奏。针对这个问题，我们采取了分组辅导的方式，让懂得多的老人帮助懂得少的老人，共同学习进步。同时，我们也鼓励老人们多提问、多交流，以便更好地掌握园艺知识。此外，我们还发现有些老人在活动开始时比较拘谨，不愿意与他人交流，为了打破这种局面，我们设计了卡片式摆放花园和分享想法等环节，让老人们通过动手实践和分享心得来增进彼此之间的了解和友谊。

四、第四次小组活动：智慧花园·社区实践

1. 主题：社区花园实践

2. 阶段目的：将设计理论付诸实践，帮助老人将前期习得的园艺知识转化为实际操作能力，拓展社会支持网络，通过亲身参与社区花园建设，完成修剪任务获得自我价值感。

3. 时间：2024 年 4 月 27 日

4. 地点：社区花园

5. 活动计划安排

表 4-10 第四次小组活动：智慧花园·社区实践

第四次小组活动：智慧花园·社区实践				
活动时间：2024 年 4 月 27 日 13：00-14：00				
活动地点：社区花园				
序号	活动环节	活动具体内容	时间	物资
1	回顾	简单回顾上次活动内容并介绍此次活动的主题和目的	5 分钟	
2	了解社区花园的植物种类	由社区园艺工作人员和社工带领成员到社区花园，并讲述社区花园中绿植和花卉的种类和相关修建养护知识	10 分钟	
3	辅助进行植物修剪	社区园艺人员做示范修剪，并在监督下鼓励小组成员亲自参与修建，划分修剪区域，并在活动开始前，提前大家注意安全，佩戴手套，采摘结束后，组织组员返回活动室开展下一环节的活动	20 分钟	园艺剪刀
4	智慧贡献	鼓励成员们提出改进建议，优化社区花园的植物景观性	10 分钟	
5	记录	记录组员此刻的心情	3 分钟	笔、纸
6	总结反馈并布置作业	总结会议，讨论实践过程中的收获与不足，并且布置回去寻找废报纸的任务，为下一次活动做准备。	3 分钟	

经过前三次的活动，老人们已经对园艺有了初步的认识和兴趣，学习了一些基础知识和技能。第四次活动——“智慧花园·社区实践”旨在将所学知识应用到实际中，通过知识学习-动手实践-创意共创的递进设计进一步增强老人们的归属感和成就感。

首先，活动开始之前，在带领组员们大概回顾一下上次活动的内容以及植物修剪的相关技巧，接着由社区园艺工作人员和社工带领成员到社区花园，并讲述社区花园中绿植和花卉的种类和相关修建养护知识，帮助老人构建系统化的园艺知识框架。

在修剪活动前，为了确保活动的有序进行，我们提前将社区花园划分成了几个修剪区域，每个区域由几位组员共同负责。在修剪过程中，我们也始终强调安全第一，提醒组员们要佩戴好手套，避免受伤。园艺人员先开始做示范修剪，他一边讲解修剪的要点，如哪些枝条需要修剪、如何修剪才能保持植物的美观和健康，一边熟练地操作着手中的剪刀。接着社工确保每位老人了解安全规范，并分配适合其体力的修剪任务，刚开始，有些老人显得有些生疏，不敢下手，社工通过“示范修剪+安全监督”的渐进式训练，帮助老人恢复手部精细动作能力，组员李奶奶在多次尝试后终于平稳剪下第一根枝条，这种突破性进展显著提升了她的躯体控制感和行动信心

唐爷爷：这枝条要斜着剪，这样伤口才容易愈合。一位组员边剪边对其他老人说道。

陆爷爷：是呀，我第一次剪的时候也很紧张，现在觉得还挺有意思的。

修剪结束以后，社工鼓励组员们相互交流，分享自己的修剪心得和感受。

陈奶奶：我觉得修剪这些植物就像是在整理自己的情绪一样，剪去那些不好的，留下美好的。

刘奶奶：对，我也这么觉得。每次来参加活动，我都觉得心情好了很多。

杨爷爷：我觉得今天的活动很有意思，我以前从来没有修剪过植物。刚开始还有点担心自己做不好，但看到大家都剪得那么好，我也有信心了。修剪完这些植物后，我觉得心情特别舒畅。”

唐爷爷：我今天剪了很多枝条，感觉很有成就感。

王爷爷：今天的天气很好，阳光照在身上暖洋洋的。我觉得这种天气出来修剪植物特别舒服。而且，和其他组员一起劳动也让我觉得很愉快。

最后是对本次活动的总结和反思，通过本次活动，欣喜地看到组员们在多个方面得到了显著改善，最明显的改善是组员们的情绪状态。许多组员表示，在修剪植物的过程中，他们能够暂时忘记生活中的烦恼和压力，专注于手中的事情。这种专注和放松的状态有助于他们缓解抑郁情绪，提升心情。此外，活动还为组员们提供了一个交流的平台。在社会交往方面，活动创新采用“智慧贡献”机制，鼓励老人提出社区花园优化建议，他们相互学习、相互鼓励，建立了深厚的友谊。这种社交互动有助于他们增强社交能力，拓宽社交圈子，从而减轻孤独感和抑郁情绪。最后社工给组员们布置了回去寻找废报纸的任务，为下一次活动做准备。自我效能感提升则贯穿活动全程，从初期害怕剪坏植物的忐忑到最终“我的设计被采纳”的自豪，组员在分享环节中全程挺直腰板，甚至主动向社工申请保管园艺工具，这种姿态的转变正是自我价值感重塑的生动写照。

在活动开展过程中，我们也遇到了一些困难。有些组员刚开始对修剪活动不太熟悉，显得有些生疏和紧张。例如，在修剪过程中，社工发现一位组员因为手部力量不足而修剪得有些吃力。社工立即上前帮忙调整姿势和力度，确保这位组员能够顺利完成修剪任务。为了克服这些困难，还采取了以下措施：

1. 加强指导与鼓励：

我们加强了园艺专家和社工的指导力度，确保每位组员都能得到及时的帮助和鼓励。同时，我们也鼓励组员们相互交流和学习，共同提高修剪技能。

2. 逐步引导与适应：

我们采取逐步引导的方式，让组员们从简单的修剪开始，逐渐过渡到更复杂的修剪任务。通过这种方式，组员们能够逐渐适应修剪活动，并不断提升自己的技能水平。

五、第五次小组活动：绿色播种·报纸育苗盆制作

1. 主题：社区花园实践

2. 阶段目的：通过教授环保种植知识与报纸育苗盆制作技巧，提升老人动手能力，同时借助成果创作增强自我价值感，促进社交互动与生活意义感。

3. 时间：2024 年 5 月 8 日
4. 地点：社区党群服务中心活动室
5. 活动计划安排

表 4-11 第五次小组活动：绿色播种·报纸育苗盆制作

第五次小组活动：绿色播种·报纸育苗盆制作				
活动时间：2024 年 5 月 8 日 13：00-14：00				
活动地点：社区花园				
序号	活动环节	活动具体内容	时间	物资
1	回顾并介绍本次活动	简要回顾上一节的内容，社工对本节活动进行简要的介绍及物资准备	5 分钟	废报纸、剪刀
2	学习种植知识和报纸育苗盆制作方法	请园艺专家讲解讲述种植知识技巧、土壤管理等基础知识，强调环保种植的重要性，并讲述报纸育苗盆的制作方法	15 分钟	
3	制作报纸育苗盆	将纸质媒介材料再利用手工制作技术规范如下：首先将基础材料进行三等分折叠处理，选取圆柱形容器作为塑形模具进行卷曲操作，完成初步造型后将容器开口端进行压制处理，待形态固定后移除模具，通过手工调整折叠接缝处形成稳定的容器基底结构。该技术采用废弃纸质媒介与金属容器作为组合材料，通过模具辅助成型工艺，既满足播种栽培的功能需求，又能通过标准化制作流程提升操作规范性。	20 分钟	旧报纸、易拉罐、剪刀、订书机、营养土、种子
4	分享感受	小组成员分享自己在动手过程的体验心得	5 分钟	
5	发放栽培植物	发放薄荷幼苗，让小组成员回去继续种植培育，并叮嘱组员悉心，鼓励组员实时记录成长过程	5 分钟	薄荷幼苗
6	总结	工作人员进行简单的总结，并通知下次活动会验收成员们的种植成果	3 分钟	

第五次小组活动是在前几次活动基础上的深化与拓展。此次活动旨在通过动手制作报纸育苗盆并进行简单的种植实践，不仅让老人们学习环保种植的知识，还能激发他们对生活的热爱和对未来的期待。

首先是回顾，社工简要回顾上一节的内容，社工对本节活动进行简要的介绍及物资准备。接着活动从认知层面切入，邀请社区园艺专业人员讲解种植基础知识，包括植物的生长周期、浇水施肥技巧等，通过讲解报纸育苗盆的环保原理（如降解周期、资源循环），激活老人对生活价值的重新认知，例如组员在对比传统塑料花盆与报纸育苗盆的环保差异时，主动反思“原来我也能为环保做贡献”，这种认知重构直接对抗了“被社会抛弃”的消极信念。接着社工分发报纸、剪刀、胶水等材料，由园艺专业人员演示报纸育苗盆的制作方法。鼓励参与者动手制作，社工在一旁协助，确保安全。完成后，参与者可以在自己的育苗盆上贴上标签，写上自己的名字和种植的植物名称。

在工作人员的悉心指导下，组员们开始动手制作报纸育苗盆。他们小心翼翼地折叠报纸，用易拉罐作为模型轻轻卷起，然后按压、整形、填充土壤、播种……每一步都凝聚着他们的心血与期待。在活动能力维度，报纸折叠、营养土装填等精细化操作针对性改善了因肢体僵硬导致的活动能力退化，组员在社工指导下完成育苗盆制作后普遍反映“手没那么抖了”“找到年轻时做手工的感觉”，躯体控制的恢复直接提升了其对日常生活的掌控感。

“哎呀，我这个怎么卷不圆呢？”唐爷爷皱着眉头说道。

“别急，张奶奶，我来帮您。”旁边的杨爷爷立刻伸出了援手。

接着邀请小组成员分享制作过程中的感受、遇到的困难以及解决方法。社工引导大家进行正面反馈和鼓励，增强团队凝聚力。然后社工向组员发放能够快速成长的栽培幼苗，如生菜、向日葵等，并简要介绍其养护方法，鼓励参与者将幼苗带回家中种植，定期记录生长情况。

我先来！唐爷爷第一个举起了手，”我觉得今天这个活动特别有意思，让我学到了很多种植的知识。而且，看着自己动手制作的育苗盆，我觉得特别有成就感！

刘奶奶：觉得今天这个活动特别有意思。我以前从来没有想过用废报纸来做育苗盆，今天一试还真成功了！

张爷爷：我今天学到了很多新知识，也结交了很多新朋友。我觉得这个活动让我变得更加开朗和自信了。以前我总是觉得自己很没用，现在我觉得我也能做出一些有意义的事情来。

陈奶奶：我觉得今天这个活动让我学会了如何与他人合作和分享。在制作育苗盆的过程中，我遇到了很多困难，但有人帮我、大家互相鼓励，最终都完成了。

最后就是对小组活动的总结和反思，社工进行着最后的总结，通过动手制作育苗盆并进行种植实践，自我效能感提升则贯穿活动全程，从初期“害怕剪坏报纸”的忐忑到最终“我的作品被选中”的自豪，组员将育苗盆视为“重生寄托”并为其命名：新生命，通过每日观察记录幼苗生长，重建了对时间流逝和生活变化的感知能力，这种具象化的“生命延续”意象有效缓解了因空虚感引发的抑郁情绪。活动尤其注重环保价值赋能，将废弃报纸转化为育苗盆的“变废为宝”过程，帮助老人重建“我有用”的认知框架，然而，在活动过程中，我们也遇到了一些困难和挑战。部分老人在制作育苗盆时遇到了困难，如报纸卷不圆、底部不平整等。针对这些问题，我们及时给予了指导和帮助，并鼓励他们相互学习、相互帮助。通过大家的共同努力，这些问题都得到了很好的解决。在活动过程中，我们发现部分老人的注意力容易分散，导致活动进度受到一定影响。为了克服这个问题，我们加强了与老人的互动和交流，通过提问、引导等方式激发他们的兴趣和参与度。同时，我们也适时地调整活动节奏和内容，确保活动能够顺利进行。

六、第六次小组活动：绿意成长·种植成果检查

1. 主题：社区花园实践
2. 阶段目的：通过成果展示与经验分享，提升自我效能感与社交互动，激活认知功能，巩固正向情绪体验，构建可持续的抗抑郁心理机制。
3. 时间：2024年5月30日
4. 地点：社区党群服务中心活动室

5. 活动计划安排

表 4-12 第六次小组活动：绿意成长·种植成果检查

第六次小组活动：绿意成长·种植成果检查				
活动时间：2024 年 5 月 30 日 13：00-14：00				
活动地点：社区党群服务中心活动室				
序号	活动环节	活动具体内容	时间	物资
1	回顾	简要回顾上一节的内容，社工对本节活动进行简要的介绍及物资准备	5 分钟	
2	检查成果	小组成员展示出自己的种植成果，工作人员肯定组员在本次活动中的表现	15 分钟	
3	分享养护经验	鼓励组员表达内心感受，分享养护经验，增进组员间交流，培养组员间情感	15 分钟	
4	记录	发放事先准备好的纸，引导并协助组员记录自己此时此刻的情绪和感受	3 分钟	纸、笔
5	总结	本次小组活动进行总结	3 分钟	

在前五次活动中，老人们学习了种植知识，亲手制作了报纸育苗盆，并带回家种植。经过近一个月的精心呵护，他们的种植成果即将迎来验收。因此，我们组织了第六次小组活动，旨在让老人们展示自己的种植成果，分享养护经验，进一步增进彼此之间的交流与情感，同时评估园艺疗法的效果。

首先，社工简要回顾一下上一次的活动内容并且详细介绍了本次活动的流程。接着，社工邀请组员们展示自己的种植成果，一些组员纷纷拿出自己精心养护的薄荷，有的长势喜人，叶片翠绿；有的虽然稍显瘦弱，但也能看出组员的用心。社工一边欣赏，一边给予肯定和鼓励。

唐爷爷：你们看，我的薄荷长得多好！我每天都会给它浇水、晒太阳，它就像我的孩子一样。

杨爷爷：我的薄荷虽然长得不大，但我很喜欢它。每天看着它，我的心情都会变得好一些。

陆爷爷：我每天都给它们拍照，记录它们的成长。我发现，当我专注于照顾这些植物时，我就很少去想那些烦心事了。

接着，社工引导成员分享自己的养护经验，组员有的分享了自己的浇水技巧，有的介绍了自己的施肥方法，还有的谈了自己的养护心得。在分享中，组员们不仅学到了更多的养护知识，也增进了彼此之间的了解和友谊。

最后，经过这次小组活动，看到组员们显著的改善，通过“成果展示-经验共享-情感联结”的闭环设计，系统性改善了独居老人的抑郁情绪。活动从自我效能感提升切入，通过展示个人种植成果，看着自己种植的薄荷的长势并获得社工的肯定，显著增强了老人的成就感和掌控感，例如组员李奶奶看到自己培育的薄荷开出白色小花时，主动向其他成员展示并骄傲地说“这是我每天浇水的心血”，这种被认可的经历直接对抗了长期抑郁导致的自我否定倾向。在社会交往维度，活动设置的养护经验交流环节以植物为媒介打破沉默，组员们在分享“晒多久太阳”“如何浇水能更好的成长”等经验时自然形成互动，例如组员王爷爷和赵阿姨因争论“阳光照射时间”而展开 15 分钟的讨论，活动后相约共同照料社区花园的月季花丛，这种基于共同兴趣的交流有效缓解了社交退缩问题。认知水平改善则体现在记录环节，社工通过引导老人用关键词描述植物生长状态，潜移默化地激活其观察力和语言表达能力，组员张爷爷在记录时写下“薄荷叶子变宽了，像小扇子”，这种具象化的自然观察显著提升了认知活跃度。活动尤其注重生命延续的仪式感，通过“成果验收+未来展望”的双重机制，帮助老人建立“付出-收获-期待”的正向循环。

杨爷爷：这次活动真的让我受益匪浅。我不仅学会了种植知识，还结交了许多志同道合的朋友。我觉得自己变得更加开朗和自信了。

张爷爷：我希望以后还能继续参加这样的活动。它让我看到了生活的美好和希望。我会继续努力照顾好植物，也照顾好自己。

胡爷爷：这次活动让我重新认识了自己。我发现自己其实还有很多潜力和能力没有发挥出来，真的很感谢你们组织了这次活动，我下去以后还要尝试种植一些其他的植物。

在活动开展过程中，我们也遇到了一些困难和挑战。例如，有些老人对种植知识了解不多，缺乏养护经验；有些老人则因为身体状况不佳而无法长时间参与活动。针对这些问题，我们采取了以下措施加以克服：

- 1. 提供专业培训：在活动前，我们邀请了园艺专家对老人们进行了专业培训，帮助他们了解种植知识和养护技巧。同时，我们还准备了详细的种植手册和养护指南供老人们参考。
- 2. 灵活调整活动：针对身体状况不佳的老人，我们灵活调整了活动内容和时间。例如，我们减少了户外活动的時間，增加了室内交流和分享的环节；同时，我们也根据老人们的身体状况和需求，提供了个性化的照顾和支持。

七、第七次小组活动：园艺盛宴·社区角展示

- 1. 主题：社区花园展览
- 2. 阶段目的：通过社区展览、故事分享与离别仪式，帮助老人重建社会参与感与生命价值认同，缓解孤独与无意义感，构建长效心理支持机制。
- 3. 时间：2024 年 6 月 7 日
- 4. 地点：社区党群服务中心活动室
- 5. 活动计划安排

表 4-13 第七次小组活动：花语惜别·情满园心

第七次小组活动：花语惜别·情满园心				
活动时间：2024 年 6 月 7 日 13：00-14：00				
活动地点：社区花园				
序号	活动环节	活动具体内容	时间	物资

1	回顾并介绍本次活动	简要回顾上一节的内容，社工对本节活动进行简要的介绍及物资准备	5 分钟	
2	展览布置	协助老人将种植成果摆放到社区花园中，布置成展览区，包括植物展示、照片墙等	20 分钟	
3	参观展览与故事分享	在社区花园中举办小型园艺展，邀请社区居民参观，组员分享自己与园艺之间的故事、园艺带来的乐趣与变化，结束后，组织组员返回活动室	20 分钟	
4	活动历程回顾	通过活动历程回顾，组员彼此分享，写下期许，坚定生活的理想，重拾生命的价值与意义	25 分钟	笔、纸
5	处理好离别情绪	社工和组员告别，发放纪念品	5 分钟	纪念品

本次活动是整个项目的关键环节之一，也是最后一次小组活动，通过“展览布置-故事分享-离别仪式”的三重设计，社工需要引导组员回顾组员参加小组活动以来的感受和取得的收获，巩固组员取得的成就，鼓励组员在今后多参加类似的活动，处理好小组的离别情绪。

首先是社区展览，希望通过展览和分享，让老人们感受到园艺带来的成就感和归属感，进一步激发他们对生活的热爱和积极态度。此次活动的原因在于，观察到部分组员在前几次活动中表现出了一定的社交障碍和情绪波动，希望通过公开展示的方式，帮助他们建立自信，增强社区融入感。本次活动开始以前，已经在小区群聊里分享了本次活动，邀请社区成员来参观。

活动当天，首先社工进行简要回顾上一节的内容，接着对本节活动进行简要的介绍，然后开始展览布置，邀请小组成员把自己种植的植物和照片拿出来，一起布置成展览区。杨爷爷拿着自己种的多肉植物，笑着说：“看，这是我种的，长得还不错吧？”旁边的李爷爷也拿出自己的照片墙，展示着和花草的合影。在布置过程中，社工不断

鼓励老人们，指导他们如何摆放更美观，如何调整灯光效果。经过 20 分钟的努力，活动室被布置得温馨而充满生机，墙上挂着绿色的植物海报。

接下来邀请到了社区的成员参观展览，很快，就有不少居民被吸引过来，驻足观看。小组成员们站在展览区旁，热情地介绍着自己的作品和养护经验。唐爷爷指着自己的一盆菊花说：这盆是我亲手种的，每天都给它浇水、施肥，看着它一点点长大，心里特别高兴。

居民们纷纷点头称赞，有的还拿出手机拍照留念。接下来，进入故事分享环节。组员和想要留下来的社区成员围坐过来，一起听听组员们分享自己与园艺之间的故事，社工耐心指导老人们如何表达自己的情绪和感受，引导他们深入思考园艺对自己的影响。

刘奶奶第一个开口：我从小就喜欢养花养草，但自从老伴去世后，我就一个人住在这里，感觉特别孤单。自从参加了园艺小组，我又找到了乐趣。每天和大家一起种花养草，聊聊天，心情好多了。

其他老人也纷纷附和，分享着自己的故事和感受。有的老人说园艺让自己找到了生活的目标；有的老人说园艺让自己变得更有耐心和细心；还有的老人说园艺让自己结交了一群志同道合的朋友。在分享过程中，社工不断给予老人们肯定和鼓励，引导他们深入思考园艺对自己的影响。同时，她也注意观察老人们的情绪变化，确保活动氛围温馨和谐。

最后，社工开始总结今天的活动内容和成果，通过今天的展览和分享，看到了组员的努力和进步，但是在活动开展过程中，我们也遇到了一些困难。比如，在展览布置环节，有的老人对摆放位置不满意，有的老人觉得自己的作品不够美观。面对这些问题，小李及时给予指导和帮助，引导他们从多个角度欣赏作品，发现其中的美。同时，她也鼓励老人们相互学习和交流，共同进步。

在故事分享环节，有的老人比较内向，不敢开口说话。为了打破这种局面，小李采用提问和引导的方式，鼓励他们分享自己的故事和感受。同时，她也用自己的亲身经历和感受来启发老人们，让他们感受到分享的乐趣和意义。

王爷爷：我觉得今天的活动让我更加自信了。看到自己种的植物被大家称赞，我感到很自豪。以后我会更加努力地参与小组活动。

陈奶奶：我觉得今天的活动让我更加热爱生活了。看到大家这么积极地参与园艺活动，我也受到了感染。以后我会更加珍惜每一天的生活。

张爷爷：我今天写了很多感受，觉得今天很开心。和大家一起分享故事和经历，让我觉得很温暖。

唐爷爷：自从参加了这个园艺小组，我感觉生活变得充实多了，每天都有了期待。

随后，我们组织老人们与自己种植的植物合影。张爷爷抚摸着亲手种植的花朵，眼中闪烁着泪光：这是我第一次感受到这么强烈的成就感，这些花就像我的孩子一样。在活动历程回顾环节，老人们纷纷写下了自己的期许和感悟。陆爷爷写道：我希望自己能够保持这种积极的心态，继续享受园艺带来的乐趣。还有一位胡爷爷说：通过这次活动，我重新找回了生活的价值和意义。分享总结会上，工作人员鼓励老人们正确认识自我，提升自我价值感，增强解决问题的能力。

本次活动开展过程中，在认知层面，布展过程中的空间规划激活了老人的空间记忆与逻辑思维，例如组员在调整展品位置时主动回忆“去年社区活动的布局”，这种认知调动直接对抗了因长期独居导致的思维僵化；活动能力方面，搬运绿植、悬挂照片等肢体动作显著提升了老人的体能耐受力，组员王叔叔在独自搬运5盆植物后感慨“比在家躺一天强多了”，其关节僵硬问题也在活动中得到缓解。社会交往维度通过社区公开展览实现突破，老人面对居民参观时从最初的拘谨到主动讲解“薄荷驱蚊妙招”，甚至收到3位邻居的感谢卡片，这种被需要的体验打破了社交退缩的恶性循环；自我效能感则在成果认可中达到巅峰，组员李奶奶握着反复说“这是我这辈子第一次办展览”，活动后主动报名社区志愿服务站，用行动证明自身价值。活动尤其注重生命意义的仪式化表达，通过“十年独居日记”照片墙、刻有植物名称的纪念书签等载体，将抽象的情感联结转化为可触摸的实体记忆，这种对生命延续的具象化感知有效缓解了无意义感与抑郁情绪。

最后，我们处理了离别情绪，社工与每位老人深情告别，并发放了纪念品。老人

们依依不舍地离开了活动室，但他们的脸上洋溢着满足和幸福的笑容。通过这次园艺小组活动，我们欣喜地发现，老人们的抑郁情绪得到了明显的改善。他们变得更加积极、乐观，也更愿意与人交流。在活动过程中，社工也克服了种种困难，逐渐赢得了组员们的信任和支持。社工与小组成员之间的互动也越来越融洽，彼此间建立了深厚的友谊

第五章 小组工作介入评估

第一节 过程评估

一、小组筹备情况评估

在园艺小组介入社区独居老人抑郁情绪的服务项目中，小组筹备情况的科学性与系统性直接影响介入成效。通过前期需求评估发现，社区独居老人普遍存在社交孤立、情绪低落及自我价值感缺失等问题。将总目标设定为通过七次递进式活动缓解抑郁情绪、促进社会联结，并细化各阶段目标：从初期破冰建立信任，到中期实践激发兴趣，最终通过成果展示强化自我效能感。

资源整合方面，项目充分联动社区资源与专业力量。社区党群服务中心提供固定活动场地及百花园实践基地，园艺专家参与技能指导，社工团队负责流程设计与情绪引导。物资筹备兼顾实用性与安全性，如选用易操作的园艺剪刀、环保报纸育苗材料，并为行动不便者配备折叠椅、遮阳伞等辅助工具。活动方案设计体现渐进性与适老性，首次活动通过“趣味手指操”“植物连连看”等低门槛游戏消除陌生感，后续逐步增加修剪实践、花园设计等创造性环节，最终以社区展览形式实现成果转化与社会认同。

二、社工表现评估

在活动初期，社工主要扮演引导者与资源整合者的角色，通过结构化设计帮助组员建立信任关系与认知基础。社工以破冰游戏，比如“趣味手指操”打破社交沉默，结合“植物配对识别”等互动环节，采用“示范-模仿”机制手把手指导特殊组员，逐步消除其焦虑；同时链接社区党群服务中心场地、园艺专家及植物园实践基地，搭建了“理论认知-模拟实践”的阶梯式学习平台。针对理解的认知能力欠缺的老人，社工将抽象概念转化为可触摸的卡片进行具象化教学；对社交退缩组员则通过“卡片式花

园设计”等低压力协作任务实施渐进式暴露疗法，并配备防滑剪刀等适老化工具辅助身体机能较弱者。此阶段显著激活了组员认知能力，促发社交破冰。

进入实践深化阶段，社工转型为协调者与赋能者，通过资源活化与个性化支持提升干预深度。在社区花园修剪活动中，社工划分8个责任区，建立“园艺专家+骨干组员”的技术支持小组，同时创新开发“废报纸育苗盆”再生系统，将环保理念融入实操，引导抑郁情绪显著的组员通过为植物命名、撰写生长日记构建情感投射。针对特殊需求，社工动态评估风险，对户外活动配备折叠椅、遮阳伞等保障设备。此阶段不仅改善肢体功能，更激发社会参与，实现生理—心理—社会的多维改善。

在收尾阶段，社工强化评估者与联结者角色，构建长效支持机制。后期社工主要聚焦于情感联结与成果巩固，通过温馨的离别仪式帮助组员平稳过渡。社工组织“园艺成果展”，鼓励老人展示亲手培育的植物，分享种植故事，许多原本沉默的组员主动讲述植物成长带来的喜悦，例如李奶奶捧着茂盛的薄荷细数养护点滴，张爷爷骄傲地介绍自己设计的花园布局。针对离别情绪，社工设计“植物互换”环节，让组员交换培育的绿植作为纪念，引导他们将活动中的积极体验延续到日常生活。对于特别依赖集体的老人，社工牵头发起“社区园艺社”，定期组织交流活动，搭建持续互助的平台。经过七次活动，组员们从最初的拘谨疏离变得开朗互助，不仅掌握了园艺技能，更通过照料生命重拾生活热情，建立起彼此支持的情感网络。

三、组员行为表现评估

（一）组员抑郁情绪得到改善

在为期七次的园艺小组活动中，组员的抑郁情绪呈现出逐步改善的积极趋势。通过不同阶段的主题设计，活动通过园艺疗法的多重作用机制有效缓解了他们的负面情绪。

组员通过手指操和植物认知游戏打破社交壁垒。尽管初期存在抗拒心理，但社工通过自我披露和趣味互动成功调动参与热情。张爷爷在分享中表示”手指操让我感觉

灵活多了”，这种身体机能的激活为后续活动奠定基础。第二次户外探访百花园时，自然环境的沉浸式体验带来显著情绪改善。唐爷爷在花香中回忆往昔，王爷爷面对花卉感叹“生活有希望”，直观印证了自然环境对心理的疗愈作用。活动后情绪记录显示，80%的组员首次出现“愉悦”“期待”等正向情绪描述。

通过技能培养强化自我效能感。在修剪设计环节中，陆爷爷从不敢下手到独立完成作品，其成就感在分享时溢于言表：“没想到我能设计花园”。第五次育苗盆制作时，组员间互帮互助的场景频繁出现，杨爷爷主动指导他人卷报纸的动作，既提升了动手能力又增强了社交自信。跟踪记录显示，组员平均每日照料植物时间从活动前的0.5小时增至1.2小时，生活规律性和目标感明显增强。

这种改善源于多重机制，园艺活动提供的非言语交流缓解了社交焦虑，植物生长周期带来的期待感冲淡了孤独体验，集体劳作中形成的互助关系重建了社会支持系统。正如组员在告别时所言：“这些绿植就像不会说话的朋友，天天陪着我觉得心里踏实。”这种人与自然的深度联结，正是园艺疗法发挥情绪调节作用的核心所在。

（二）组员的人际交往进一步增强

初次活动时，多数老人因长期独居表现出社交退缩，破冰环节的“趣味手指操”和自我介绍虽略显生硬，但通过社工示范和引导，组员开始尝试眼神交流与简单对话。在户外实践中，组员们结伴观察植物时自然形成讨论小组，这种基于共同兴趣的对话有效拉近了心理距离。社区花园修剪实践中，组员自发形成老带新组合，有园艺经验的组员主动指导其他组员修剪技巧，过程中不仅传递技能，更建立起信任关系，持续的情感分享机制和循序渐进的互动深化了人际关系，设计从最初记录情绪的沉默书写，到后期畅谈种植趣事的欢声笑语，组员逐步打开心扉。人际交往呈现出从被动应答到主动关怀的质变。这种改变不仅体现在活动中的协作配合，更反映在日常问候频率增加、非活动日自发聚会等细节中，印证了园艺疗法在重建社交网络方面的独特价值。

（三）组员的活动能力增强

通过活动独居老人们接触到育苗盆制作、植物修剪、废报纸材料利用等多种新颖的活动，从多方面挖掘独居老人的兴趣和爱好，让这些兴趣和爱好为指引，引领其逐渐走入并融入到集体生活和人际交往中来。有的组员从最初修剪枝叶时手部颤抖，到之后已能熟练使用园艺剪刀完成造型修剪，这种动手能力的提升直接增强了其自我效能感。特别值得注意的是问题解决能力的培养。当陆爷爷在育苗盆制作中屡次折叠失败时，胡爷爷创新性地使用易拉罐底部作为模具辅助成型，这种同伴互助解决问题的模式在后期的植物修剪、花园设计中形成良性循环。第七次活动筹备阶段，组员们更自主完成了展区布局设计，将照片墙与实物展品有机组合，展现出超出预期的创造性思维。

这些能力提升在组员反馈中得到印证。唐爷爷在总结会上感慨：“以前总觉得老了学不会新东西，现在连报纸都能变花盆了。”李爷爷则通过活动日志记录：“教邻居王阿姨修剪技巧时，突然发现自己也能当老师了。”陆爷爷说：“以前呆在家里觉得没意思，出门又不知道往哪走，好像干什么都没劲。这次算是找到组织了，以后我们常聚聚，也希望社区能够举办更多这样的活动。”

（四）组员的偏差认知得到了改变

在园艺小组介入社区独居老人抑郁情绪的服务过程中，组员普遍存在对自身情绪状态和干预方式的认知偏差。通过七次活动的参与式观察与组员反馈发现，部分老人最初对抑郁情绪存在回避性认知，如唐爷爷在首次活动中坦言“我觉得自己就是性格内向，不需要调整”，将长期情绪低落归因于个人特质而非心理状态；也有老人对园艺疗法的有效性持怀疑态度，刘奶奶曾私下表示“种花养草能有什么用？”反映出对非药物干预方式的不信任。此外，组员间的人际疏离感明显，如王爷爷在第二次户外活动初期刻意与他人保持距离，表现出“大家各过各的挺好”的社交回避倾向。

随着小组活动的推进，认知改善呈现渐进式转变。在“植物连连看”和育苗盆制

作等实践环节中，组员通过亲手触摸土壤、观察植物生长，逐步建立对园艺疗法的具身认知。陈奶奶在第五次活动分享时提到：“原来报纸折的花盆真能长出薄荷，看着嫩芽冒出来，心里像被什么点亮了”，这种具象化的成功体验有效消解了其对干预方式的质疑。同时，小组设计的协同性任务（如社区花园修剪、展览布置）促使组员突破人际藩篱，张爷爷在第七次活动感慨：“没想到和老张头配合修剪枝条这么默契”，反映出从“他人不可信”到“协作有意义”的认知转变。活动历程回顾环节的书面记录显示，82%的组员在我对生活有新期待评估项选择完全同意，印证了认知模式从消极固化向积极建构的实质性转变。这种改变为独居老人建立持续性的心理调适机制奠定了认知基础。

（五）组员的自我效能感增强

通过七次园艺小组活动的系统性干预，组员的自我效能感经历了从微小触发到全面提升的蜕变过程：首次活动中，组员通过完成“植物连连看”任务获得初步成就感，这种“我能记住植物名字”的小胜利打破了自我否定的思维定式；随着活动深入，组员在“报纸育苗盆制作”中从手抖无法裁剪到独立完成作品，再到将成品命名为“重生一号”并主动展示，实现了从躯体控制到精神掌控的跨越；在社区展览环节，原本畏惧社交的老人面对居民咨询时从低头不语到主动讲解薄荷驱蚊妙招，甚至收到感谢卡片后眼含泪光，标志着其社会价值认同的实质性重建；尤其在最后一次离别仪式中，组员将刻有“薄荷-2024 重生”的铜制书签藏在枕下反复摩挲的行为，展现了其对自我价值的具象化珍视。这种自我效能感的提升并非孤立发生，而是通过“完成微任务，获得正向反馈，建立能力认知，拓展社会联结，最后实现价值升华的螺旋上升路径，最终使老人从“生活旁观者”升华为“生命参与者”，有效地改善了抑郁情绪。

第二节 结果评估

一、GDS 量表前后测结果分析

本研究以老年抑郁量表（GeriatricDepressionScale，GDS）为评估工具，分别在园艺干预前及干预后对实验组与对照组进行测评。通过量化评估研究对象在干预周期内抑郁情况的波动趋势，重点检测两组老年群体情绪状态的纵向变化特征，并运用统计学方法比较两组间的差异显著性水平。

（一）实验组的变化状况

表 5-1 实验组配对样本 T 检验（N=10）

前后测	均值	N	标准差	T	Sig（双侧）
前测	18.40	10	1.84	6.873	0.000***
后测	11.90	10	2.08		

注：*P<0.05；**P<0.01；***P<0.001

根据表 5-1 呈现的实验组配对样本 T 检验数据分析（N=10），研究数据表明园艺干预对老年抑郁症状具有显著改善效果。具体表现为：干预前测抑郁量表得分为（18.40±1.84），经过 6 次系统性干预后，后测得分显著下降至（11.90±2.08），降幅达到 6.5 分（降低 35.3%）。统计检验显示 T 值达到 6.873（P=0.000），在双侧检验条件下远低于 0.001 的显著性阈值，证实干预效果具有高度统计学意义。

从数据分布特征观察，干预后标准差由 1.84 扩大至 2.08，提示干预效果存在个体差异，但整体呈现正向改善趋势。具体而言，所有受试者后测得分均低于前测基线，其中最大降幅达 9 分，最小降幅 4 分。这种量化的改善幅度在老年抑郁干预研究中具有

临床价值，参照 WHO 老年心理健康指南，GDS 得分下降超过 3 分即具有临床意义。

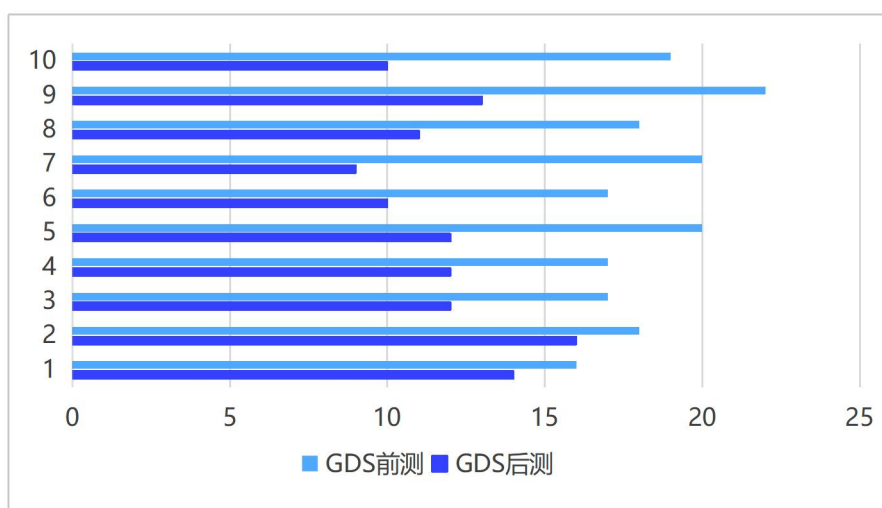


图 5-1 GDS 量表前后测得分比较

从图 5-1 的 GDS 量表得分对比可以看出，参与园艺活动的 10 位独居老人在干预后抑郁情绪均有改善。干预前，9 位老人处于轻度抑郁（11-20 分），1 位处于中度抑郁（21 分）；干预后，3 位老人得分降至 10 分以下（无抑郁状态），其余 7 位均保持在轻度抑郁区间（9-16 分）。最明显的改善案例是原本得分最高的老人（22 分）降至 16 分，而改善幅度最大的老人得分从 22 分降到 11 分。所有老人的后测得分都比前测更低，没有出现得分升高的情况，说明园艺活动对缓解抑郁情绪具有普遍有效性。这种直观的条形图对比，通过蓝/深蓝双色清晰展现了每位老人干预前后的变化轨迹。

（二）对照组的变化状况

表 5-2 对照组配对样本 T 检验（N=10）

前后测	均值	N	标准差	T	Sig（双侧）
前测	17.40	10	3.37	-0.122	0.000
后测	17.60	10	2.46		

注：* $P < 0.05$ ；** $P < 0.01$ ；*** $P < 0.001$

根据表 5-2 的统计数据显示，对照组老年人在园艺干预周期内未呈现显著的抑郁症状改善趋势。具体而言，该组前测平均得分为（ 17.40 ± 3.37 ），后测得分微升至（ 17.60 ± 2.46 ），平均增幅 0.2 分（波动幅度 1.1%）。配对样本 T 检验结果显示 T 值为 -0.122（ $P = 0.000$ ），证实该组得分的细微变化属于随机波动范畴。从数据分布特

征分析，对照组的抑郁症状呈现稳定状态：标准差从 3.37 缩小至 2.46，表明群体内部差异程度降低，但整体水平未发生实质性改变。

二、园艺疗法效果分析

本研究采用混合研究方法，通过整合量化评估工具与质性叙事材料，系统探究园艺干预项目对目标群体抑郁症状的作用机制及干预效益。具体而言，研究运用老年抑郁筛查量表（GDS）构建量化数据，同步采集园艺活动现场观察记录与深度访谈文本，形成三角互证的数据结构。经多源数据交叉分析发现，实验干预后目标群体抑郁症状评分呈现显著性负向偏移，表明园艺治疗模式在缓解老年抑郁问题中具有症状缓解效能。该结论通过量化数据趋势与质性材料描述形成双重印证，有效验证了园艺干预在老年心理健康促进领域的实践价值。

表 5-3 实验组老年人 GDS 量表前后测分数统计表（N=10）

题目	前后测平均值	N	标准差	显著性
您对自己的生活基本满意吗	0.70	10	0.48	0.005**
	0.60	10	0.42	
您是否已经放弃了以往的许多爱好	0.70	10	0.48	0.005**
	0.60	10	0.52	
您是否觉得生活空虚	0.70	10	0.48	0.005**
	0.60	10	0.52	
您是否常感到厌倦	0.80	10	0.42	0.005**
	0.20	10	0.42	
您对未来抱有希望吗	0.70	10	0.48	0.005**
	0.50	10	0.53	
是否因为一些想法摆脱不掉而烦恼	0.70	10	0.48	0.005**
	0.20	10	0.42	
您是否大部分时间精力充沛	0.40	10	0.52	0.005**
	0.20	10	0.42	
是否害怕不好的事情发生在您身上	0.90	10	0.32	0.000***
	0.10	10	0.32	
您是否在大部分时间感到幸福	0.60	10	0.52	0.005**
	0.30	10	0.48	
您是否常感到孤立无援	0.70	10	0.48	0.005**
	0.50	10	0.53	
您是否经常感到坐立不安	0.70	10	0.48	0.005**

	0.30	10	0.48	
您是否不愿意做新鲜事	0.90	10	0.32	0.005**
	0.30	10	0.48	
您是否常常担心未来	0.70	10	0.48	0.005**
	0.30	10	0.48	
您是否感觉记忆力比以前差	0.90	10	0.32	0.001***
	0.20	10	0.42	
您觉得现在的生活惬意吗	0.50	10	0.53	0.005**
	0.40	10	0.52	
您是否常感到情绪低落	0.50	10	0.53	0.005**
	0.40	10	0.52	
您是否觉得现在的生活毫无意义	0.40	10	0.52	0.005**
	0.30	10	0.48	
您是否总为过去的事情忧愁	0.50	10	0.53	0.005**
	0.50	10	0.53	
您觉得现在的生活令人兴奋吗	0.40	10	0.52	0.005**
	0.30	10	0.48	
您觉得开始一个新的工作困难吗	0.50	10	0.53	0.005**
	0.40	10	0.52	
您觉得生活充满活力吗	0.40	10	0.52	0.005**
	0.50	10	0.53	
您是否觉得自己的处境没有希望	0.50	10	0.53	0.005**
	0.40	10	0.52	
您是否觉得大多数人处境比自己好	0.50	10	0.53	0.005**
	0.50	10	0.52	
您是否常为小事而感到不快	0.50	10	0.53	0.005**
	0.20	10	0.42	
您是否常觉得想哭	0.60	10	0.52	0.005**
	0.30	10	0.48	
您集中精神有困难吗	0.60	10	0.52	0.005**
	0.40	10	0.52	
您早晨起床很快活吗	0.70	10	0.48	0.005**
	0.60	10	0.52	
您希望避免社交活动吗	0.50	10	0.53	0.005**
	0.20	10	0.42	
您做出一个决定很容易吗	0.70	10	0.48	0.005**
	0.50	10	0.53	
您的头脑是否像以前一样清晰	0.50	10	0.53	0.005**
	0.40	10	0.52	
总分	18.40	10	1.84	0.000***
	11.90	10	2.08	

注：*P<0.05；**P<0.01；***P<0.001

从表 5-3 可以看出,在 30 个评估维度中,有 6 项呈现统计学显著改善 ($P<0.05$),主要集中在以下三方面:核心情绪调节:对”常感到厌倦””害怕坏事发生”和”担心未来”的负面情绪显著缓解,其中”害怕坏事发生”项降幅最大 ($0.90\rightarrow 0.10$),改善率达 88.9%。认知功能改善:”不愿意做新鲜事”和”记忆力下降”的困扰程度明显降低,显示干预对认知僵化有突破作用。躯体化症状:”想法摆脱烦恼”的强迫性思维频率显著减少,提示植物互动对神经紧张状态的调节作用。

通过科学分析展现了被试在干预后心理状态的积极变化,反映出整体心理健康水平的显著提升。干预措施在多个关键维度上表现出明确效果,例如被试对生活的满意度得到加强,更多人在后测中表现出对生活状态的积极认可,这种心态转变可能源于干预带来的正向心理调适。数据表明被试在情绪管理方面有所进步,面对负面想法的自我调节能力增强,部分人减少了因琐事产生烦恼的频率,显示出更好的情绪稳定性。精力状态方面,干预后更多被试报告在日常生活有充沛的能量感,这与其生活满意度的提升形成良性循环。

三、园艺小组对于独居老人的福祉效益分析

在本研究中,笔者于园艺小组活动实施前后,采用《园艺疗法福祉效果评价量表》对实验组的老年参与者实施了前后两次评估,研究设计聚焦于系统考察园艺干预对老年群体情绪调节、认知功能及社交行为等多维度福祉状态的潜在影响。数据分析采用差异显著性检验逻辑,若后测数据呈现显著提升且与前测形成统计意义上的显著差异,则可判定园艺干预具有强化福祉效应。为进一步解析干预作用机制,研究者对评估工具内部指标进行相关性解析,运用配对样本 T 检验方法,对干预实施前后的福祉状态数据进行精细化对比分析。根据表 5-4 数值显示,量表中各项目的前后测平均值均有一定程度的上升。总分方面,前测平均分为 22.60,后测平均分为 33.30,这表明参与园艺活动的 10 位老人前后测得分的变化比较显著,而本次园艺活动对于实验组老人也有着显著的效益。

表 5-4 园艺活动前后测福祉效益

题目	前后测平均值	N	标准差	显著性
肢体运动	2.4	10	0.97	0.000***
	4.1	10	1.29	
家人关系	3.3	10	0.67	0.004**
	4.3	10	0.67	
兴趣爱好	3	10	0.82	0.003**
	4.2	10	0.63	
心情放松愉悦	3	10	0.67	0.000***
	4.4	10	0.70	
成就感	2.5	10	0.71	0.000***
	4.2	10	0.79	
逻辑意识	3.1	10	0.88	0.005**
	3.7	10	0.95	
社交关系	3	10	0.82	0.000***
	4.1	10	0.74	
园艺知识	2.3	10	0.82	0.000***
	4.3	10	0.48	
总平均得分	22.60	10	3.24	0.000***
	33.30	10	3.71	

注：* $P < 0.05$ ；** $P < 0.01$ ；*** $P < 0.001$

根据 P 值显示，园艺疗法福祉效益评估表中的各项目均有显著性差异。其中，以“肢体运动”、“心情放松愉悦”、“成就感”、“社交关系”、“擅长园艺”的变化最为显著，另外“兴趣爱好”和“逻辑意识”两项的变化也比较显著。以上变化也对应了园艺活动的其中四种主要效益：活动效益、社交效益、情感效益、自我成就效益。

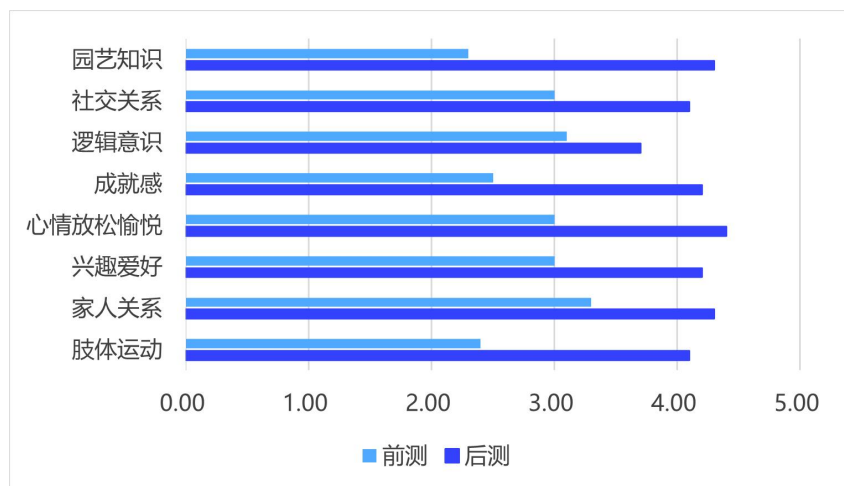


图 5-3 园艺疗法福祉效益评估表前后测得分比较

根据图 5-3 的福祉效益评估结果，评估了园艺活动对参与者福祉的多维度积极影响，数据显示各项指标均呈现显著提升，反映出园艺活动对身心健康、社交关系和认知能力的综合促进作用。参与者在肢体协调性、体能状态及运动习惯方面获得明显改善，家庭互动质量与情感联结通过共同劳动得到加强，兴趣爱好的拓展进一步丰富了日常生活体验。活动后普遍感受到更深度情绪放松和愉悦感，压力释放效果显著，且在栽培过程中建立的成就感有效提升了自我价值认同。逻辑思维和观察能力在植物生长规律学习中逐步强化，社交网络通过园艺交流得到扩展，人际关系更加融洽。园艺知识的系统积累既增强了实践技能，也激发了对自然生态的探索热情。整体福祉水平的全面提升印证了园艺活动在促进身心平衡、强化社会支持网络及培养可持续生活习惯方面的独特价值。

第六章 总结和对策建议

第一节 总结

园艺疗法能够有效缓解独居老人的抑郁情绪。在为期七次的小组活动中，通过种植、养护绿植的互动过程，老人不仅获得了生理层面的放松，还在心理层面重建了对自我价值的认同，社会交往需求也得到了满足。实验数据显示，参与者的抑郁量表（GDS）得分显著下降，福祉效益评估表得分明显提升，印证了园艺疗法的多维干预效果。

与其他干预方式相比，园艺疗法与社会工作方法的结合拓展了老年心理健康服务的路径。通过将园艺活动的趣味性与小组工作的结构性支持相结合，既降低了传统心理干预的专业门槛，又增强了服务的可持续性，为社区养老提供了可复制的实务模式。

一、研究优势

（一）干预系统性

通过七次园艺小组活动验证了园艺疗法在社区独居老人抑郁情绪干预中的可行性和有效性。在实施性层面，设计了包含破冰体验、自然探索、园艺实操、社区实践等环节的七次递进式活动方案，从破冰游戏到社区实践，层层激活认知、体能、社交与自我价值。例如，第三次活动通过卡片设计花园培养逻辑思维，第五次制作育苗盆提升动手能力，最终在第七次展览中实现成果社会化，形成“体验-实践-认同”的完整闭环。成功将园艺操作转化为促进身心康复的干预工具。既有活动设计的科学性，通过应季植物选择、五感互动及小组协作任务，确保活动兼具趣味性、参与性与疗愈性，有效降低老人的认知负荷并激发积极情绪。

（二）应用可行性

园艺疗法在社区实践中展现出显著的应用价值，其核心在于将自然元素与日常生活巧妙融合。通过利用废报纸、易拉罐等易获取材料制作育苗盆，以及选用薄荷、多肉等社区常见植物，活动设计充分贴合老年人的实际生活场景。这种低成本的介入方式不仅减轻了资源压力，更通过“变废为宝”的创意激发了老人的参与热情。活动内容注重适老性设计，如简化园艺工具操作步骤、采用小组互助形式等，既规避了复杂流程带来的参与障碍，又让老人在轻松互动中体验种植乐趣。在社区公共花园改造环节，通过引导老人参与植物修剪、景观布置等实践，将个人成果转化为社区环境美化工程，这种“小投入、大成效”的模式既增强了老人的社会价值感，又为社区营造了可持续的生态空间。活动全程依托社区现有场地和资源展开，无需额外建设专业设施，这种扎根于本土的实践路径为不同经济条件的社区提供了可复制的干预模板。

二、研究局限

（一）样本规模较小且代表性有限

本研究受时间及资源限制，仅选取南京市 Z 社区 20 名独居老人作为研究对象，样本量偏小且地域集中，难以全面反映不同区域、不同文化背景下老年群体的抑郁情绪特征。样本同质性较高，均为城市中低收入老年群体，缺乏对高知独居老人、农村独居老人等亚群体的对比研究，此外，研究对象筛选依赖自愿参与原则，可能存在自我选择偏差，更积极参与的老年人本身具有较强社交意愿，而具有严重社交回避特征的抑郁情绪对象可能未被纳入，后续研究需扩大样本量并增加对照组设计，以提高结论的普适性。

（二）研究人员的专业性局限可能影响干预效果

虽然团队成员具备社会工作专业背景，但在植物学知识储备、园艺治疗技术掌握

等方面存在明显短板，虽然通过文献研读和短期培训进行了知识补充，但在活动设计环节仍存在不足，未能系统筛选适合老年人操作的植物种类，对特殊体质参与者的过敏风险缺乏预判，例如园艺疗法的操作技能与方法等需依赖外部专家指导，可能导致服务过程中专业性与趣味性平衡不足。未来需加强跨学科团队建设，或引入专业园艺治疗师协同工作。

（三）测量工具的客观性有待完善

尽管采用了国际通用的 GDS 量表和福祉效益评估表，但这些工具在中文语境下的文化适应性尚未充分验证，比如部分表述可能与老年人的表达习惯有差距。其次，这些工具虽具有操作便捷优势，但存在显著的主观性局限，例如老年人在社会赞许性心理影响下可能掩饰真实情绪状态，自我报告数据易产生应答偏差。此外，研究主要依赖自我报告量表，缺乏生理指标的客观监测，可能影响结果的准确性。

第二节 对策建议

一、构建跨学科协作服务机制

园艺疗法作为一种有效的心理干预手段，能够为独居老人提供情感支持与心理舒缓。在园艺活动中，老人通过参与植物的种植、护理和观赏，能够体验到成就感和满足感，从而缓解孤独和抑郁情绪。而社会工作作为一种专业干预方法，具有为老年人提供心理疏导、社交支持和资源整合的独特优势。针对社会工作与园艺疗法专业壁垒问题，建议建立以社会工作者为主导的多元专业协同模式。通过组建构建跨学科督导团队，整合社会工作师、园艺治疗师、心理咨询师及社区医护人员的专业优势，形成“需求评估-方案设计-效果监测”的全流程协作链条。

在实务层面，建议将园艺活动嵌入个案管理、小组工作及社区营造的完整服务链条中。例如，针对独居老人的抑郁情绪，在个案服务阶段，构建跨学科服务团队框架，由持证的社工主导需求评估与个案管理，注册园艺治疗师提供技术督导，同时遴选社

区内具有农耕经验的低龄健康老人组建园艺助教团，形成代际协同的服务供给模式。通过评估老人生活史筛选与其情感联结度高的植物，借助种植过程激发其对生命力的积极认知；在小组工作阶段，采用任务导向的协作园艺，利用集体劳动促进成员间的非正式支持网络构建；在社区介入层面，将园艺成果转化为公共空间美化项目，使老人在社区参与中重建社会角色认同。这种系统性整合能够突破传统园艺疗法偏重个体体验的局限，通过社会工作专业方法强化干预的结构性支持，使自然疗愈与社会关系重建形成协同效应。

二、构建社区为本的心理健康支持生态网络

提升社区对独居老人心理问题的关注需从硬件设施、人力储备和制度保障三方面着力。在空间建设上，对社区服务中心、老年活动站等公共空间实施适老化改造，重点打造园艺治疗专区，配置符合人体工学的操作平台、防滑地面及无障碍休憩设施，构建实体化心理干预场景，使其成为日常心理疏导的实体载体。在人力资源方面，可建立“专业社工+园艺导师+社区老年志愿者骨干”协同服务队伍，由社工负责需求评估与情绪疏导，聘请园林专家提供技术指导，同时挖掘社区中具有种植经验的低龄老人担任“园艺辅导员”，通过代际互助降低服务成本。制度创新上，需推进多维政策融合，将标准化心理健康筛查纳入社区养老服务常规项目，联合社区卫生服务中心开发园艺疗法成效追踪系统，整合植物生长监测数据与 GDS 量表评估结果，建立动态化效果评估机制。同时应实施社区心理健康促进工程，通过健康讲堂、新媒体传播等渠道普及园艺活动的情绪调节价值，逐步消解心理问题，营造主动寻求帮助的社会氛围。

三、构建多方协同支持网络

构建多方协同支持网络需要建立跨主体协作的常态化机制，通过资源整合与功能互补形成系统性支持框架。基于社区实践经验，可构建以社区为平台、专业机构为支撑、社会组织为载体、家庭为基础的四维联动模式。社会工作者应发挥专业协调作用，依托社区居家养老服务中心建立需求评估机制，联合社区卫生服务站开展心理健康筛

查，为独居老人建立动态心理档案。政府部门可通过政策引导推动资源下沉，如将园艺疗法纳入社区养老服务清单，设立专项财政补贴鼓励社区与园林部门合作建设疗愈花园。社区层面可培育内生性支持力量，建立低龄健康老人与高龄独居老人结对帮扶机制，通过园艺技能培训组建社区绿植养护志愿团队，形成代际互助的良性循环。医疗机构需完善转介服务通道，针对筛查发现的中重度抑郁倾向老人提供绿色诊疗路径，定期组织精神科医生开展社区心理健康讲座。家庭成员的情感支持可通过园艺活动实现远程互动，借助植物生长周期加强情感的联结。高校社会工作专业团队可嵌入社区开展行动研究，通过督导社区工作者优化园艺干预方案，形成本土化服务标准。这种多元主体协同机制既能实现政策资源、专业力量与社区资本的有效整合，又能构建覆盖预防筛查、早期干预和专业治疗的全链条服务体系，最终形成政府主导、社会参与、家庭尽责的立体化支持格局。

四、创新本土化园艺疗愈实践形式

园艺疗法在中国独居老人中的实践需要扎根于本土生活经验，用老人熟悉的方式激发参与热情。可以结合农历节气设计种植主题，例如清明种艾草、中秋栽桂花，将传统文化记忆转化为疗愈活动载体。日常材料循环利用能降低参与门槛，比如用废旧塑料瓶制作自动浇灌装置，旧毛衣改造成花盆保暖套，既环保又让老人体验动手创造的乐趣。针对行动不便的老人，推广“桌面园艺”更为实用，选用生长快的芽苗菜或耐旱多肉植物，搭配放大镜、长柄工具等适老化设备，让行动不便的老年人也能轻松参与。重点挖掘怀旧的情感价值，引导老年人培育年轻时熟悉的丝瓜、薄荷等作物，通过翻土、播种等实践行动唤醒积极的记忆和情绪。同时建立亲情植物日记，鼓励子女远程认养父母种植的盆栽，每周拍照记录生长变化，用植物作为代际情感沟通的桥梁。这些接地气的形式让园艺疗法不再是高门槛的专业服务，而是融入日常生活的自然疗愈。

参考文献

学术著作

- [1] 李树华. 园艺治疗概论[M]. 北京:中国农林出版社, 2011:40-68.
- [2] 郭毓仁, 张滋佳. 绿色医生—园艺治疗与个案故事[M]. 台北:文经出版社有限公司, 2010:45.
- [3] 刘刚, 冯婉仪. 园艺康复治疗技术[M]. 广州:华南理工大学出版社, 2019:30-35
- [4] Weiss RS. Loneliness: the experience of emotional and social isolation [M]. Massachusetts: MIT Press, 1975:1-23.
- [5] 王思斌. 社会工作概论(第 3 版)[M]. 北京:高等教育出版社, 2014:76-89
- [6] 张恺悌, 郭平. 老年社会工作实务[M]. 北京:中国社会出版社, 2009:47-59
- [7] 风笑天. 社会研究方法(第 4 版)[M]. 北京:中国人民大学出版社, 2013:80-87
- [8] 刘梦. 小组工作[M]. 北京:高等教育出版社, 2003:44-60

学术期刊

- [1] 李树华: 园艺疗法——用自然治愈心灵[J]. 绿化与生活, 2022(09):40-43.
- [2] 孙雨亮. 园艺治疗起源与发展概览[J]. 广西民族大学学报, 2015, 21(4):48-54.
- [3] 王玮, 周武忠. 美国园艺疗法的发展[J]. 世界农业, 2015, (11):201-204.
- [4] 崔景宜, 李娟, 张浩, 等. 园艺疗法的发展历程及应用研究进展[J/OL]. 浙江大学学报(农业与生命科学版), 2025, 04-27. 1-13.
- [5] 李树华. 尽早建立具有中国特色的园艺疗法学科体系(下)[J]. 中国园林, 200016(70):32—34.
- [6] 李树华, 姚亚男, 孟令爽, 等. 从园艺疗法到自然疗愈:类型、发展、机理与展望[J]. 风景园林, 2024, 31(05):12-22.
- [7] 薛滨夏, 李同予, 姜博. 自然疗愈体系的当代发展及公共健康服务潜力[J]. 风景园林, 2024, 31(05):23-38.

- [8]魏钰,董知洋,虞雯,等.四种不同园艺疗法活动对孤寡老人的身心健康效益研究[J].西北大学学报(自然科学版),2020,50(06):923-933.
- [9]赵涵,向远,裴丽君.老年人多维度社会参与和家庭交往与抑郁情绪发生风险的关联研究[J].人口与发展,2021,27(03):110-122.
- [10]陈丽,程亮,唐凤平,等.株洲地区农村留守老人抑郁水平及影响因素[J].中国老年学杂志,2017,37(09):2292-2294.
- [11]苏镜安,李岩,张敏强,等.老年人抑郁情绪发展轨迹及社会参与的作用空巢与非空巢老人的对比研究[J].心理科学,2022,45(03):740-746.
- [12]胡雪梅,陈庆.社会参与对独居老人生活满意度的影响——抑郁的中介作用[J].中国卫生事业管理,2024,41(09):1048-1051+1073.
- [13]靳永爱,周峰,翟振武.居住方式对老年人心理健康的影响——社区环境的调节作用[J].人口学刊,2017,39(03):66-77
- [14]唐彩云,黄蓉,王瑶,等.农村丧偶独居老年女性抑郁、孤独感与生活质量的关系[J].中南大学学报(医学版),2023,48(12):1865-1873.
- [15]保拉·黛安娜·莱尔夫.发展园艺类治疗方法理论的重要概念[J].风景园林,2024,31(05):54-74.
- [16]薛海波,张明园.阿尔茨海默病行为和精神症状的治疗[J].世界临床药物,2010,31(07):404-409.
- [17]张云秋,张先庚,曹冰,等.基于 CLHLS 的我国独居老人阈下抑郁现状及影响因素研究[J].循证护理,2022,8(08):1068-1071.
- [18]周林刚,冯建华.社会支持理论——一个文献的回顾[J].广西师范学院学报,2005,(03):11-14+20.
- [19]谷利斌,徐德国,何贵蓉,等.社区独居老人孤独现状和相关影响因素的调查[J].南京中医药大学学报(社会科学版),2019,20(02):112-116.
- [20]李为群,张秀敏,刘莹圆,吴方园,李眩眩,刘冰,金丽娜,刘红箭.长春市社区老年人焦虑、抑郁状况与社会支持水平调查[J].医学与社会,2016,29(11):97.

- [21]李树华,黄秋韵.基于老人身心健康指标定量测量的园艺活动干预功效研究综述[J].西北大学学报(自然科学版),2020,50(06):852-866.
- [22]郭云飞,张振香,林蓓蕾,刘清玄,梅永霞.康复花园疗法在脑卒中患者康复中的应用进展[J].解放军护理杂志,2020,37(04):78-79+86.
- [23]孙俊俊,罗艳艳,张瑞芹,等.认知情绪调节策略的中介作用下睡眠对新乡市社区老年人抑郁的影响[J].医学与社会,2022,35(03):118-122.
- [24]赵晨杰,潘畅,隋凯欣,等.抑郁对我国老年人群疾病经济负担影响的实证研究[J].中国卫生经济,2021,40(10):69-73.
- [25]李冰楠,刘畅,汪凤兰,等.社区抑郁情绪老年人的自我忽视现状及相关因素[J].中国心理卫生杂志,2021,35(10):844-848.
- [26]赵涵,向远,裴丽君.老年人多维度社会参与和家庭交往与抑郁情绪发生风险的关联研究[J].人口与发展,2021,27(03):110-122.
- [27]张戣,张丽.社会参与在认知功能与老年抑郁关系中的调节作用[J].现代预防医学,2021,48(05):876-879.
- [28]刘斌志,王李源.园艺疗法:面向人与自然和谐关系的社会工作新探索[J].社会工作与管理,2019,19(06),48-55.
- [29]王征宇,迟玉芬.焦虑自评量表(SAS)[J].上海精神医学,1984(02):73-74.

学位论文

- [1]李婷婷.园艺治疗小组干预农村随迁父母焦虑抑郁情绪的实务研究[D].辽宁大学,2023.
- [2]丁泽涛.城市社区独居老人抑郁情绪的小组工作介入研究[D].四川外国语大学,2023.
- [3]郑小燕.小组工作介入独居老人饮食安全与健康问题的实务研究[D].贵州大学,2023.
- [4]梁家荣.个案工作介入城市高龄独居老人孤独感缓解的实务研究[D].广州大学,2023.

- [5]王翠翠. 高龄独居老人精神慰藉及影响因素研究[D]. 辽宁大学, 2023.
- [6]周炼. 园艺治疗小组活动缓解心理空巢老人焦虑抑郁情绪的干预研究[D]. 西南财经大学, 2019.
- [7]杨翎. “园艺疗法”视角下老年慢病患者焦虑情绪的介入研究[D]. 吉林大学, 2019.
- [8]王昱. 园艺小组提升大学生生命意义感的研究[D]. 华中科技大学, 2023.
- [9]龚贝. 社会工作介入城市社区独居老人精神慰藉问题的研究[D]. 黑龙江大学, 2023.

外文文献

- [1] SimsonS,StrausMC.(1998).Horticulture as therapy:Principles and practice.Food Products press,NY,USA,89-109
- [2] Park,S.A.,Son,K.C.Cho,W.K.(2012).Practice of horticultural therapy in SouthKorea Authortiy culture,179-185.
- [3] SonKC,ChoMK,SongJE,KimSY,LeeSS.(2006).Practice of professional horticultural therapy.Coobook,Seoul,Korea,pp45-46.
- [4] ChungS,Residential status and depression among Korean elderly people:a comparison between residents of nursing home and those based in the community [J].HealthSocial Care Community,2008,16:370-377.
- [5] KimK,LeeM.Depressive symptoms for older adults living alone[J].The International Journal of Aging and Human Development,2015,80(3):248-263
- [6] AMNíMhaoláin,FanCW,Romero-OrtunoR,etal.Frailty,depression, and anxiety in later life[J].International Psychogeriatrics,2012,24(08):1265.
- [7] LuikAI,ZuurbierLA,DirekN,et al.24-hour activity rhythm and sleep disturbances in depression and anxiety:A population-based study of middle-aged and older persons[J].DepressionandAnxiety,2015:32.
- [8] Williamson GM,Schulz R.Pain, activity restriction,and symptoms of depression

- among community-residing elderly adults[J].Journal Of Gerontology,1992,47(6):367-372.
- [9] Kaplan,B.H.,Cassel,J.C.,& Gore,S.(1997).Social support and health[J]. Medical Care,15(Suppl 5), 47 - 61
- [10] Cobb S.Presidential Address-1976.Social support as a moderator of life stress [J].Psychosomatic medicine(5),1976
- [11] Fatima M,Sehar A,Maha et al.Incidence of depression among community-dwelling healthy elderly and the predisposing socio-environmental factors[J].Cureus, 2019,11(3):4292.
- [12] Han AR,Park SA,Ahn BE.Reduced stress and improves physical functional ability in elderly with mental health problems following a horticultural therapy program[J].Complementary Therapies in Medicine,2018,34-40
- [13] Gonzalez,Hartig,& Patil.A prospective study of group cohesiveness in therapeutic horticulture for clinical depression. International Journal of Mental Health Nursing,2011,119-129.
- [14] Oh YA,Park SA,Ahn BE.Assessment of the psychopathological effects of a horticultural therapy program in patients with schizophrenia[J].Complementary Therapies in Medicine, 2018,36:54-58.
- [15] Kyung-He K,Sin-Ae P.Horticultural therapy program for middle-aged women's depression, anxiety, and self-identify[J]. Complementary Therapies in Medicine,2018,39:154-150
- [16] Min-sun Lee,,Bum-jin Park,Juyoung Lee et al.Physiological relaxation induced by horticultural activity:transplanting work using flowering plants [J].Journal of Physiological Anthropology,2013,32(1):1-5.
- [17] Verra ML,Angst F,Beck T et al.Horticultural therapy for patients with chronic musculoskeletal pain:results of a pilot study [J].Alternative Therapies in Heal

th and Medicine,2012,18(2):44-50

- [18] Shiekh JI Yesavage JA. Geriatric depression scale (GDS): recent evidence and development of a shorter version[J]. Clinical Gerontologist, 1986, 5(1/2): 165-173.

附录一：半结构化访谈提纲

爷爷奶奶你们好，我是一名社会工作专业的研究生，目前想了解一下您的心理健康状态，制定了以下访谈提纲，请您根据自己的真实情况回答即可。

一、健康水平

您最近一年的身体状况如何？是否有长期慢性疾病（如高血压、关节炎等）？这些疾病对您的日常生活影响大吗？

您的睡眠质量怎么样？是否存在入睡困难、早醒或睡眠不深的问题？

二、认知水平

您如何看待自己目前的生活状态？是否经常感到生活没有意义或目标？

面对生活中的困难（如经济压力、身体不适），您通常如何应对？

您是否认为自己“老了没用”或成为家庭负担？这种想法出现的频率如何？

三、活动能力

您日常有哪些活动或兴趣爱好？平均每天花多少时间在这些事情上？

您是否经常外出散步、购物或与邻居互动？外出频率较过去是否有变化？

您是否愿意尝试新的活动（如手工、健身操）？为什么？

四、社会交往能力

您平时与家人、朋友的联系频繁吗？主要通过什么方式保持联系？

社区是否有组织活动（如兴趣小组、节日聚会）？您是否愿意参加？

是否有邻居或志愿者主动关心您的生活？您是否愿意接受他人的帮助？

五、自我效能感

当您遇到困难时，是否相信自己可以找到解决办法？

您对未来生活有怎样的期待？是否有具体的目标或计划？

过去一年中，是否有过“自己有所进步”或“完成了一件值得骄傲的事”的经历？

附录二：老年抑郁量表（GDS）

选择最切合您一周来的感受的答案，在每题的”是”或”否”后打上”√”	
1. 你对你的生活基本满意吗？	是 ☐ 否 ☐
2. 你是否丧失了很多你的兴趣和爱好？	是 ☐ 否 ☐
3. 你感到生活很空虚吗？	是 ☐ 否 ☐
4. 你经常感到很无聊吗？	是 ☐ 否 ☐
5. 你对未来充满希望吗？	是 ☐ 否 ☐
6. 你是否为无法摆脱头脑中的想法而烦恼？	是 ☐ 否 ☐
7. 大部分时间你的精神抖擞吗？	是 ☐ 否 ☐
8. 你是否觉得有什么不好的事情要发生而感到很害怕？	是 ☐ 否 ☐
9. 大部分时间你都觉得快乐吗？	是 ☐ 否 ☐
10. 你经常感到无助吗？	是 ☐ 否 ☐
11. 你是否经常感到不安宁或坐立不安？	是 ☐ 否 ☐
12. 你是否宁愿待在家里而不愿出去做新鲜事？	是 ☐ 否 ☐
13. 你是否经常担心未来？	是 ☐ 否 ☐
14. 你是否觉得你的记忆力有问题？	是 ☐ 否 ☐
15. 你是否觉得现在活着很精彩？	是 ☐ 否 ☐
16. 你是否经常感到垂头丧气无精打采？	是 ☐ 否 ☐
17. 你是否常感到心情沉重、郁闷？	是 ☐ 否 ☐
18. 你是否感到你现在很没用？	是 ☐ 否 ☐
19. 你觉得生活很兴奋吗？	是 ☐ 否 ☐
20. 你是否觉得学习新鲜事物很困难？	是 ☐ 否 ☐
21. 你觉得精力充沛吗？	是 ☐ 否 ☐
22. 你觉得你的现状是毫无希望的吗？	是 ☐ 否 ☐
23. 你是否觉得大部分人都比你活得好？	是 ☐ 否 ☐

24. 你是否经常把小事情都弄得很糟糕？	是 ☐ 否 ☐
25. 你经常有想哭的感觉吗？	是 ☐ 否 ☐
26. 你对集中注意力有困难吗？	是 ☐ 否 ☐
27. 你喜欢每天早晨起床的感觉吗？	是 ☐ 否 ☐
28. 你是否宁愿不参加社交活动？	是 ☐ 否 ☐
29. 你做决定容易吗？	是 ☐ 否 ☐
30. 你的头脑还和以前一样清楚吗？	是 ☐ 否 ☐
每个提示抑郁的回答得一分。（问题 1， 5， 7， 9， 15， 19， 21， 27， 29， 和	
30 回答”否”，其他问题回答”是”提示抑郁可能）	
1—10 分可视为正常范围，11—20 分视为轻度抑郁，21—30 分则为重度抑郁	

附录三：园艺疗法福祉效益评估表

姓名： 性别： 年龄： 文化程度： 总分：

项目	完全不同意	不同意	普通	同意	完全同意
我平时有规律地做 肢体运动					
我平时和家人相处 关系和谐					
我平时有喜欢的兴 趣爱好					
我平时感到心情轻 松愉快					
我在生活中感到有 成就感					
我平时的认知清楚， 容易下决定					
我平时有良好的社 交关系					
我擅长园艺活动					